



Nuansa
Fajar
Cemerlang

MENSTRUAL HYGIENE MANAGEMENT PADA REMAJA

Umi Aniroh
Tina Mawardika



MENSTRUAL HYGIENE MANAGEMENT PADA REMAJA

Ns. Umi Aniroh,M.Kes.

Ns.Tina Mawardika,M.Kep.,Sp.Kep.Mat.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Menstrual Hygiene Management pada Remaja

Penulis: Ns. Umi Aniroh, M.Kes.
Ns. Tina Mawardika, M.Kep., Sp.Kep.Mat.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Tata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7139-15-3

Cetakan Pertama: Februari, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram : @bimbel.optimal



PENERBIT:

Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)

PRAKATA

Alhamdulillah, Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penulisan Monograf ***Menstrual Hygiene Management pada Remaja***. Dalam penyusunan monograf ini, penulis telah berupaya semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan penulis demi penyelesaian monograf ini, tetapi sebagai manusia biasa, penulis tidak luput dari keterbatasan dan kesalahan baik dari teknik penulisan, tata bahasa maupun isi dari monograf itu sendiri. Kami menyadari tanpa arahan serta masukan dari berbagai pihak yang telah membantu, mungkin kami tidak bisa menyelesaikan monograf ini tepat waktu. Monograf ini disusun semata-mata hanya untuk memberikan khasanah dan wawasan tambahan kepada para pembaca tentang *Menstrual Hygiene Management* pada Remaja serta sebagai motivasi dalam berkarya khususnya pada karya tulis.

Maka dengan kerendahan hati penulis hanya bisa menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian monograf ini.

Semoga monograf ini dapat bermanfaat dan mudah dipahami bagi penulis khususnya serta para pembaca pada umumnya.

(Desember, 2024)

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv

BAB 1 PENDAHULUAN..... 1

BAB 2 TINJAUAN UMUM REMAJA 5

A. Pengertian Remaja	5
B. Perubahan Psikologis Remaja	6
C. Perubahan Fisiologis Remaja.....	8
D. Tahap Perkembangan Remaja.....	11
E. Karakteristik Masa Remaja.....	14

BAB 3 FISIOLOGIS MENSTRUASI..... 19

A. Pengertian Menstruasi.....	19
B. Usia Menstruasi	20
C. Tanda dan Gejala Menstruasi	21
D. Fisiologis Menstruasi	21
E. Siklus Menstruasi	22
F. Faktor yang Mempengaruhi Menstruasi.....	22
G. Persiapan Menghadapi Menstruasi.....	24

BAB 4 MENSTRUAL HYGIENE MANAGEMENT 31

A. Pengertian <i>Menstrual Hygiene Management</i>	32
B. Tujuan dan Manfaat Menstrual Hygiene.....	34
C. <i>Menstrual Hygiene Management</i>	35
D. Dampak Menstrual Hygiene yang buruk.....	37

BAB 5 DUKUNGAN SOSIAL TEMAN SEBAYA	41
A. Dukungan Sosial	41
B. Sumber-Sumber Dukungan Sosial	45
C. Dukungan Teman Sebaya	46
D. Manfaat Dukungan Teman Sebaya	47
E. Sasaran Kelompok Dukungan Teman Sebaya.....	49
F. Pembentukan Kelompok Dukungan Teman Sebaya.....	50
G. Peran dan Fungsi Teman Sebaya	59
H. Dimensi dan Aspek Dukungan Teman Sebaya	62
 BAB 7 PENUTUP.....	 69
 DAFTAR PUSTAKA	 71
 GLOSARIUM	 85
 PROFIL PENULIS	 89

BAB 1

PENDAHULUAN

Menstruasi merupakan salah satu indikator kematangan seksual pada remaja putri. Ketika remaja putri sudah mulai menstruasi, hal utama yang harus diperhatikan adalah kebersihan pada saat menstruasi (*menstrual hygiene*) karena saat menstruasi ini sering dihubungkan dengan beberapa kesalahpahaman praktik kebersihan diri selama menstruasi yang dapat merugikan kesehatan bagi remaja (Dasgupta dalam Aniroh,et.al,2019). Menurut (Kusumastuti,2016),salah satu fenomena yang masih terjadi saat menstruasi adalah perilaku higienis remaja pada saat menstruasi yang masih rendah.

Menurut *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) tahun 2015 menyebutkan bahwa telah terjadi peningkatan kesadaran akan dampak praktik pengelolaan menstruasi terhadap kesehatan, pendidikan, dan psikososial bagi wanita dan remaja putri di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Penelitian yang dilakukan di Asia, Afrika, dan Amerika Latin menjelaskan beberapa tantangan yang dihadapi wanita, seperti akses yang buruk terhadap informasi yang lengkap tentang pengetahuan menstruasi,pengelolaan darah menstruasi, ketidakcukupan air, sanitasi dan fasilitas yang tidak memadai, keyakinan sosial-budaya yang menyesatkan serta pantangan-pantangan yang dianggap tabu.

Penjagaan kebersihan menstruasi sangatlah penting karena akan menghindarkan dari munculnya keluhan pada organ reproduksi yang sering terjadi yaitu infeksi, iritasi dan rasa

gatal pada organ genitalia oleh karena penggunaan pembalut dalam waktu yang lama. Akibat kurangnya pemahaman *menstrual hygiene management* (MHM) berisiko terjadi gangguan kesehatan reproduksi seperti keputihan, Infeksi Saluran Kemih (ISK), Penyakit Radang Panggul (PRP) dan kemungkinan terjadi kanker leher rahim (Wakhidah & Wijayanti, 2014).

Saat menstruasi seharusnya setiap remaja putri benar-benar dapat menjaga kebersihan organ reproduksi secara ekstra terutama pada area genitalia, karena jika tidak dijaga kebersihannya, akan menimbulkan akumulasi mikroorganisme yang berlebih sehingga mengganggu fungsi organ reproduksi (Burnet Institute, 2015). Untuk menghindarkan dari keluhan-keluhan tersebut diperlukan perilaku pengelolaan atau manajemen kebersihan menstruasi yang baik.

Menurut Skinner, perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap suatu proses atau reaksi seseorang oleh paparan stimulus (rangsangan dari luar) terhadap organisme yang kemudian organisme tersebut merespon. Perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. Sikap seseorang terhadap suatu objek juga akan mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung pada praktik atau tindakan, karena sikap sebagai suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan (Ningsih et al., 2021). Oleh karena itu, pengetahuan yang baik dan sikap yang mendukung menjadi faktor penting untuk terjadinya perilaku, begitu pula pengetahuan dan sikap memiliki hubungan yang signifikan dengan perilaku menjaga kebersihan selama menstruasi (Widarini et al., 2023). Pengetahuan berhubungan secara signifikan dengan manajemen kebersihan menstruasi yang baik (Nnennaya et al., 2021).

WHO menyerukan adanya kecukupan informasi melalui promosi hak-hak perempuan dan remaja putri yang sedang menstruasi dan memenuhi kebutuhan kesehatan menstruasi mereka secara komprehensif dengan kemudahan akses fasilitas air, sanitasi, pembuangan dan perawatan agar menstruasi dapat dilalui secara sehat (Burnet Institute,2015) serta perlunya dukungan sosial, terutama dari teman sebaya (*peer support*), karena dukungan inilah yang berperan dalam menguatkan perilaku. Teman sebaya penting bagi remaja karena merupakan tempat pertama kali mereka hidup bersama dan bekerja sama dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kelompok sebaya (Novitasari,2014). Selain itu, lingkungan teman sebaya merupakan lingkungan yang dapat memberikan rasa nyaman bagi remaja (Kharisma & Latifah,2015), oleh karenanya teman sebaya memiliki peran yang tidak dapat diabaikan dalam menstrual hygiene management bagi remaja.

BAB 2

TINJAUAN UMUM REMAJA

A. Pengertian Remaja

Remaja merupakan pemahaman berasal dari bahasa latin *adolensence* yang memiliki arti tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan dapat diartikan sebagai adanya perubahan secara fisik yang mampu diukur melalui angka seperti bertambahnya berat badan dan tinggi badan. Sedangkan perkembangan meliputi semua proses pematangan yang dialami seseorang sebagai persiapan memulai fase selanjutnya itu masa dewasa. Masa remaja adalah masa yang penting dan perlu mendapatkan perhatian khusus karena dalam perjalanan pada setiap fase kehidupan manusia, karena pada masa tersebut menjadi fase peralihan dari masa kanak-kanak yang bebas ke masa dewasa yang menuntut tanggung jawab sehingga mampu membawa diri dalam setiap situasi dan kondisi (Amalia, 2022).

Perpindahan masa kanak-kanak menuju masa dewasa sering kita kenal dengan masa dewasa. Menurut *World Health Organization* (WHO) seseorang dikatakan menginjak masa remaja jika sudah berusia 10-18 tahun, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun, sedangkan berdasarkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) rentang usia remaja adalah 10-21 tahun dan belum pernah melewati fase pernikahan (Mawardika, 2019). Pada masa tersebut seorang manusia dikatakan masuk dalam satu waktu yang kita kenal dengan

masa remaja. Perkembangan dan pertumbuhan pada masa ini berjalan sangat cepat baik secara fisik. Berdasarkan kondisi tersebut seorang manusia yang memasuki kategori remaja dikategorikan dalam beberapa tahap perkembangan dari pra remaja sampai dengan remaja akhir (Diananda, 2019).

Perempuan yang sudah memasuki fase pubertas atau masa remaja ditandai dengan adanya perubahan secara fisiologis dan perubahan secara psikologis (Proverawati, 2017)

B. Perubahan Psikologis Remaja

Perubahan secara psikologis remaja yang memasuki masa pubertas mengalami berbagai macam perubahan dalam beberapa ranah yaitu aspek kognitif, moral, sosial dan emosi yang terjadi pada saat seorang manusia berada diantara masa anak-anak sampai dengan masa dewasa (Mawardika, 2024).

Berdasarkan penelitian Mawardika dan team tahun 2024, disebutkan perubahan psikologis yang berhubungan dengan mental remaja antara lain:

1. Perubahan mental yang dialami oleh remaja putri, sebagian besar memiliki tingkat sensualitas yang cukup tinggi misalnya lebih mudah memiliki perasaan cemas dan gelisah, bahkan terkadang ada yang sampai tahap frustrasi jika tidak tertangani dengan baik. Tanda lain yang muncul adalah adanya kondisi agresif. Agresif disini dapat diartikan peka terhadap rangsangan atau hal-hal yang mengganggu dan berpengaruh terhadap kondisi mental remaja tersebut, melakukan kegiatan secara tergesa-gesa tanpa memikirkan kembali dampaknya secara jangka

panjang dan memiliki pribadi yang suka mencari perhatian.

2. Perkembangan kecerdasan atau inteligensia, yaitu kemampuan seseorang khususnya remaja untuk mampu belajar dari pengalaman yang sudah terjadi dengan menggunakan pengetahuan untuk mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru atau kita kenal dengan kemampuan beradaptasi.
3. Memiliki konsep pikir yang abstrak dan lebih gemar memberikan kritik atas semua yang terjadi di lingkungan sekitar remaja tersebut berada.
4. Memiliki rasa penasaran yang tinggi sehingga berusaha mencoba-coba terhadap hal-hal yang baru.

Menurut Marwoko (2019), tahap perkembangan psikologis yang terjadi pada remaja yaitu:

1. Perkembangan emosi remaja
Perubahan fisik dan kelenjar yang dialami oleh seorang remaja membuat remaja berada dibawah tekanan sehingga menyebabkan timbulnya ketegangan emosi. Ketegangan emosi yang dialami oleh remaja memungkinkan pada sesuatu yang membawa pada dampak positif maupun dampak negative. Perubahan emosi yang sering dialami oleh remaja pada tahap awal munculnya rasa cemas, malu, marah takut bahkan bisa timbul iri hati. Perasaan emosi yang bersifat negative tersebut terjadi karena remaja tidak bisa mengontrol emosinya dengan baik.
2. Perkembangan kecerdasan (inteligensia) dan kognitif
Lingkaran saraf *portal lobe* akan mengalami pembaharuan ketika seseorang menginjak masa remaja. Aktivitas berfikir atau kognitif tingkat atas tidak bisa lepas dari peran *Prontal lobe*. Lingkaran saraf *prontal lobe*

tersebut memiliki peran penting terhadap kemampuan kognitif remaja, sehingga remaja mampu mengembangkan kemampuan berfikir yang memberinya suatu tingkat kesadaran sosial dan pertimbangan moral yang baru. Selanjutnya kemampuan baru yang dimiliki remaja berupa sebuah penalaran dalam penyelesaian masalah, membuat remaja mampu membuat suatu pertimbangan dan melakukan perdebatan, dalam perkembangan kecerdasan dan kemampuan berfikir remaja terjadi peningkatan dalam pengambilan keputusan dan kemampuan berfikir sosial

3. Perkembangan remaja secara sosial

Perkembangan remaja secara sosial biasanya akan menimbulkan suatu permasalahan seperti adanya dorongan untuk dapat dipaksakan menjadi individu yang mandiri dan krisis orignalitas, konformitas golongan remaja dalam mengisi waktu luang, hubungan dengan orangtua, perkembangan proaktivitas dan seksualitas.

C. Perubahan Fisiologis Remaja

Perubahan fisiologis atau fisik yang terjadi pada remaja ditandai dengan adanya perubahan fungsi fisiologis dan penampilan fisik terutama pada kelenjar seksual (Kusmiran, 2014). Perubahan fisiologis merupakan gejala utama dalam pertumbuhan seorang remaja dalam daur siklus kehidupannya. Perubahan fisik tersebut akan membawa dampak pada perubahan mental atau psikologis. Perubahan yang terjadi dalam dua kategori yakni perubahan secara eksternal seperti berat badan, tinggi, badan badan, organ seks, proporsi tubuh dan perubahan internal seperti sistem pernafasan, pencernaan, endokrin, peredaran darah, jaringan tubuh.

Menurut Marmi (2023) menyatakan bahwa pada wanita timbul tanda-tanda perubahan fisiologis secara primer dan tanda-tanda perubahan fisiologis secara skunder.

1. Perubahan primer pada remaja perempuan.

Perubahan primer pada remaja perempuan ditandai dengan datangnya menstruasi pertama atau yang sering kita kenal dengan menarche. Menarche merupakan tanda perubahan primer pada remaja perempuan. Pada masa ini terjadi perubahan organ-organ reproduksi yang sudah mencapai tahap kematangan. Ovarium atau indung telur mulai matang karena pengaruh hormon hipofisis dan hormon gonadotropin, folikel yang mulai tumbuh meski belum matang akan berusaha mengeluarkan hormon esterogen, hormon esterogen berpengaruh dalam kecepatan pertumbuhan seorang perempuan dan pertumbuhan badan juga dipengaruhi oleh korteks kelenjar suprarenal membentuk hormon androgen.

2. Perubahan skunder pada remaja perempuan

a. Pinggul

Tulang pinggul dan lemak yang berada di bawah kulit akan bertambah besar sehingga pinggul tampak menjadi lebih lebar, membesar dan membulat.

b. Payudara

Karena pengaruh perubahan hormon tidak hanya pinggul membesar namun diikuti oleh payudara juga membesar dan putting susu yang semakin menonjol, pembesaran pada bagian payudara dipengaruhi oleh kelenjar susu.

c. Rambut

Rambut pada remaja Perempuan merupakan ciri khas dari pertumbuhan sekunder pada remaja Perempuan. Pertumbuhan rambut tidak hanya di kepala namun

dibeberapa bagian tubuh lainnya yang sering kita kenal dengan bulu. Bulu kemaluan muncul pada area setelah pinggul dan payudara mulai berkembang. Mulai muncul bulu pada beberapa bagian wajah dan bulu ketiak mulai muncul seiring dengan hadirnya menstruasi pada remaja perempuan.

d. Kulit

Bagian kulit remaja putri tampak menjadi lebih kasar dari sebelumnya, lebih tebal, dan pori-pori menjadi tampak lebih besar, sehingga memungkinkan muncul permasalahan jerawat pada seseorang yang menginjak usia remaja.

e. Otot

Otot pada remaja putri menjadi semakin kuat dan membesar sehinggahi terbentuk bahu, lengan, serta tungkai kaki.

Menurut Mawardika (2019), tanda perubahan pada remaja sebagai berikut:

1. Tanda-tanda perubahan fisik pada remaja putri secara primer

Sebagian besar organ reproduksi perempuan tumbuh selama masa remaja dengan tingkat kecepatan yang berbeda-beda pada setiap orang, munculnya menstruasi pertama atau sering kita kenal dengan menarche dianggap sebagai petunjuk pertama bahwa sistem kerja organ reproduksi perempuan yang memasuki masa menjadi matang. Tanda dan gejala ini merupakan awal dari serangkaian keluarnya darah, lendir dan jaringan sel yang hancur dari uterus secara berkala menuju ke vagina, dan akan berhenti ketika wanita mencapai tahap berhentinya menstruasi yang kita kenal dengan menopause.

2. Tanda-tanda perubahan fisik pada remaja putri secara skunder.

Pada masa ini, remaja putri akan mengalami pertumbuhan fisik yang lebih cepat dari sebelumnya. Ciri-ciri perubahan seksual yang terjadi pada remaja putri seperti pinggul menjadi semakin bulat dan lebar, pori-pori bertambah besar namun kulit menjadi lebih halus. Ciri perubahan fisik skunder pada wanita selanjutnya adalah kondisi dimana kelenjar keringat dan kelenjar lemak lebih aktif, dan kondisi sumbatan kelenjar lemak yang tidak mendapatkan intervensi dengan tepat dapat menyebabkan timbulnya jerawat.

D. Tahap Perkembangan Remaja

Tahap perkembangan yang dialami oleh remaja dimulai dari tahap pra remaja, remaja awal, remaja tengah, sampai dengan remaja akhir (Batubara, 2016).

1. Pra Remaja (11-12 tahun)

Tahap Pra remaja mempunyai masa yang sangat singkat, kurang lebih hanya berjangka satu tahun; untuk laki-laki usia 12- 13 sedangkan pada Perempuan 11-12 tahun. Pada fase pra remaja ini sering dikenal dengan fase negatif, karena pada fase ini seorang remaja cenderung terlihat perilaku yang bersifat negatif. Pada fase tersebut sebagian besar seorang remaja menjadi tampak lebih sukar untuk menjalin hubungan komunikasi dengan orang tua. Perubahan hormonal pada seorang remaja mengakibatkan perkembangan fungsi-fungsi tubuh menjadi terganggu sehingga berdampak pada perubahan suasana hati yang tidak bisa kita prediksi sebelumnya. Remaja memiliki cirikhas berupa peningkatan reflektivenes tentang diri mereka yang berubah

berhubungan dengan apa yang orang pikirkan tentang pribadi remaja tersebut

2. Tahap remaja awal (12-15 tahun)

Pada fase ini sebagian remaja merasa tercengang terhadap perubahan fisik (primer dan skunde) dan perubahan mental yang terjadi pada dirinya serta berbagai dorongan yang menyertai perubahan tersebut. Pada tahap ini remaja mulai mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi sehingga cenderung mengembangkan pikiran-pikiran baru, cepat tertarik pada lawan jenis, mencoba segala hal-hal yang baru dan mudah terangsang secara seksual. Suatu kondisi perasaan peka berlebihan yang dimiliki remaja ini disertai dengan minimnya pengendalian terhadap ego akan menyebabkan remaja menjadi lebih sulit untuk dipahami dan mengerti terhadap orang dewasa.

Pada tahap ini perubahan pada remaja terjadi begitu cepat bahkan mencapai tahap puncaknya. Pada rentang usia tersebut seorang remaja mengalami kondisi yang tidak stabil pada banyak hal disertai dengan adanya ketidakseimbangan emosional. Pada fase ini seorang remaja berusaha mencari jati diri, statusnya tampak tidak jelas. Beberapa pola hubungan sosial yang terjalin mulai nampak berubah. Sikap remaja pada fase ini menyerupai orang pada tahap perkembangan dewasa muda, dimana remaja sering merasa mempunyai hak atas dirinya untuk membuat suatu keputusan dirinya sendiri. Pada masa tahap perkembangan ini, perubahan yang paling menonjol adalah pencapaian kemandirian dan identitas, pemikiran yang dimiliki oleh seorang remaja menjadi semakin logis, abstrak, tidak beraturan, idealistis bahkan semakin banyak

waktu yang mereka curahkan diluar lingkup keluarganya sendiri.

3. Tahap Remaja Tengah atau Madya (15-18 tahun)

Pada tahap remaja tengah ini seseorang membutuhkan teman-teman dalam kehidupannya. Mereka lebih cenderung memiliki perasaan narsistik yaitu rasa percaya diri dan mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, salah satunya dengan cara lebih menyukai sahabat yang memiliki sifat yang sama atau sefrekuensi dengan dirinya. Remaja pada fase ini berada dalam kondisi kebingungan terhadap segala sesuatu yang mereka hadapi karena masih ragu harus memilih yang mana, antara segala sesuatu yang bersifat positif atau negatif, peka atau peduli, optimis atau pesimis, ramai-ramai atau sendiri.

4. Tahap remaja akhir (18-21 tahun)

Pada tahap remaja akhir ini mereka ingin menjadi pusat perhatian; berusaha ingin menonjolkan apa yang ada pada dirinya; cara yang dilakukan berbeda dengan yang berada pada tahap perkembangan remaja awal. Remaja pada tahap akhir lebih cenderung memiliki sikap idealis, mempunyai harapan dan cita-cita yang tinggi, lebih bersemangat dan mempunyai energi yang lebih banyak. Mereka berusaha memantapkan identitas diri, dan ingin mencapai kemandirian secara emosional.

Tahap remaja akhir mempunyai ciri khas yang mendekati kedewasaan ditandai dengan berbagai pencapaian, yaitu:

- a. Minat atau keinginan yang semakin mantap dengan fungsi-fungsi yang ada.
- b. Perasaan Ego untuk mencari kesempatan bersatu dengan orang atau teman yang memiliki sifat yang

sama dan rasa keingintahuan tahapan yang tinggi dengan harapan Ketika mencobal hal yang baru akan mendapatkan suatu pengalaman baru.

- c. Terbentuknya kemantapan identitas seksual yang permanen sehingga tidak akan berubah lagi.
- d. Perasaan Egosentrisme tergantikan dengan keseimbangan antara kepentingan yang dimiliki oleh diri sendiri dengan kepentingan yang dimiliki oleh orang lain.
- e. Munculnya batasan antara diri sendiri dengan orang lain atau masyarakat umum.

E. Karakteristik Masa Remaja

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitria & Mawardika (2023), karakteristik dari remaja yakni

1. Masa Remaja sebagai Masa Peralihan

Masa peralihan disini dapat diartikan sebagai suatu peralihan yang terjadi tidak terputus dengan atau berubah dari apa yang telah terjadi sebelumnya, akan tetapi lebih mengutamakan pada sebuah peralihan dari satu tahap ke tahap perkembangan berikutnya. Tingkat perilaku individu dipengaruhi oleh perubahan fisik yang terjadi pada saat seorang remaja berada pada fase awal. Pada setiap periode peralihan tahap perkembangan remaja, status yang dimiliki oleh individu belum jelas dan terdapat perasaan ragu akan peran yang harus dijalankan. Pada periode ini, remaja bukan lagi didefinisikan sebagai seorang anak dan juga tidak bisa dikatakan sebagai orang dewasa, namun berada pada fase peralihan. Dalam kondisi seperti ini akan memberi remaja sebuah keuntungan, karena situasi tersebut akan memberikan waktu pada remaja untuk mencoba hal yang baru atau

gaya hidup yang berbeda dengan sebelumnya dan menentukan pola pikir serta pola perilaku, nilai dan sifat yang paling sesuai bagi dirinya sendiri.

2. Masa Remaja sebagai Masa Perubahan

Tingkat perubahan fisik yang dialami oleh seorang remaja sejajar dengan tingkat perubahan sikap dan perilaku yang mereka tampilkan. Selama pada tahap remaja awal, ketika terjadi perubahan fisik baik secara primer maupun secara skunder terjadi dengan pesat, perubahan sikap dan perilaku berlangsung dengan pesat. Menurut Aniroh (2024) terdapat empat perubahan yang bersifat universal dan cenderung sama pada fase ini, yakni:

- a. Terjadi peningkatan emosi, yang intensitasnya tergantung pada tingkat perubahan fisik dan psikologi yang dialami oleh seorang remaja. Perubahan informasi biasanya berlangsung lebih cepat terjadi pada saat remaja memasuki tahap permulaan, maka kondisi peningkatan emosi lebih menonjol pada masa awal periode seorang remaja.
- b. Perubahan fisik, peran dan minat yang diharapkan oleh kelompok sosial untuk dijalankan atau diperankan, akan menimbulkan suatu permasalahan baru. Pada fase remaja permasalahan baru yang timbul akan menjadi lebih banyak dan sulit untuk diselesaikan jika dibandingkan dengan permasalahan sebelumnya. Remaja akan memiliki perasaan penuh masalah, sampai mereka mampu menyelesaikannya menurut pemikirannya.
- c. Terjadi perubahan pola perilaku dan minat, maka akan diiringi oleh perubahan nilai. Terjadi sebuah kontradiksi dimana adanya anggapan tentang sesuatu

hal yang dianggap penting pada masa anak-anak, namun sekarang menjadi suatu hal yang tidak penting Ketika mereka (remaja) beranjak dewasa. Salah satu contohnya, sebagian remaja mempunyai anggapan bahwa banyaknya teman merupakan merupakan bukanlah petunjuk pada kondisi popularitas yang lebih penting dibandingkan dengan sifat-sifat yang diakui, dikagumi dan dihargai oleh teman sebayanya. Remaja mulai memahami bahwa kualitas yang dimiliki lebih penting dari kuantitas yang dimiliki dalam dirinya.

- d. Sifat ambivalen terhadap setiap perubahan sering terjadi pada sebagian besar remaja. Mereka memiliki keinginan dan menuntut sebuah kebebasan, tetapi mereka sering mengalami perasaan takut untuk bertanggung jawab terhadap akibatnya dan meragukan kemampuan mereka untuk dapat mengemban tanggung jawab tersebut.

3. Masa Remaja sebagai Usia yang Menimbulkan Ketakutan

Banyak anggapan populer atau menjadi terkenal di kalangan remaja yang memiliki arti yang bernilai, tetapi banyak diantaranya yang berkonotasi negatif seperti remaja yang tampilannya kurang rapih, yang kurang mampu untuk di percaya dan cenderung memiliki perilaku merusak. Seseorang yang berada pada tahap perkembangan dewasa memiliki kewajiban untuk memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap kehidupan seorang remaja agar mampu menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan memiliki sikap dan perilaku yang normal.

4. Masa Remaja sebagai Masa yang Tidak Realistis

Kehidupan yang dijalani cenderung dilihat oleh seorang remaja sesuai dengan keinginannya. Remaja beranggapan untuk melihat orang lain dan diri pribadinya sebagaimana yang mereka harapkan dan bukan apa adanya kondisi tersebut, terutama dalam hal cita-cita yang merupakan sebuah harapan yang akan mereka rengkuh atau mereka capai. Keinginan yang kurang realistis bukan hanya untuk dirinya sendiri namun juga berlaku untuk keluarga dan teman-temannya sekitar, yang dapat menyebabkan meningkatnya emosi sebagai ciri masa remaja pada tahap awal. Semakin tidak realistis keinginan atau harapan yang mereka inginkan akan menyebabkan remaja tersebut untuk tersulut emosi atau lebih sensitif dan rentan untuk marah. Remaja akan memiliki perasaan kecewa dan sakit hati apabila orang lain membuat dirinya menjadi kecewa, atau apabila cita-cita yang ditetapkannya tidak tercapai oleh remaja tersebut. Dengan bertambahnya pengalaman yang diperoleh oleh seorang remaja serta pengalaman sosial, dan meningkatnya kemampuan untuk berpikir secara rasional, remaja yang memiliki kemampuan memandang diri sendiri, keluarga, teman-teman dan kehidupan pada umumnya secara realistis.

5. Masa Remaja sebagai Ambang Masa Dewasa

Semakin beranjak pada masa yang lebih matang yaitu masa dewasa, para remaja menjadi lebih gelisah untuk meninggalkan *stereotip* belasan tahun, untuk memberikan efek bahwa remaja merupakan pribadi yang mendekati masa dewasa. Namun kemampuan untuk menampilkan dirinya seperti cara mereka mengenakan pakaian dan membawa dirinya dalam berperilaku seperti layaknya orang dewasa ternyata belum cukup. Oleh sebab

itu, remaja mulai memantaskan diri pada perilaku yang mendekati status dewasa, yaitu merokok, minum-minuman keras, mengkonsumsi narkoba, dan melakukan perbuatan seks agar mendapatkan pengakuan dalam kategori orang dewasa. Remaja memiliki anggapan bahwa perilaku yang mereka lakukan tersebut akan memberikan citra sesuai yang mereka inginkan yaitu menjadi pribadi dewasa.

BAB 3

FISIOLOGIS MENSTRUASI

A. Pengertian Menstruasi

Menstruasi pertama kali dialami oleh seorang perempuan saat menginjak masa pubertas. Terjadinya menstruasi merupakan salah satu tanda kematangan secara fisiologis pada seorang perempuan. Proses menstruasi yang paling awal dialami oleh seorang perempuan kita kenal dengan *Menarche* (Sari, 2021). Hampir sebagian besar perempuan pasti mengalami menstruasi. Kondisi yang dialami seorang perempuan tersebut sebagai tanda bahwa perempuan memiliki fungsi organ reproduksi yang sehat bahkan hal tersebut erat kaitannya dengan kesuburan. Meskipun demikian setiap perempuan memiliki proses yang berbeda-beda dalam menjalaninya (Mawardika & Aniroh, 2023).

Menstruasi sering disebut dengan "*haid*" yang memiliki pemahaman bahwa jika seorang perempuan mengalami perdarahan dari vagina atau jalan lahir (Mawardika, 2019). Pada setiap bulannya sistem reproduksi perempuan akan mempersiapkan sebuah proses penting dalam kehidupan manusia yaitu kehamilan, dimana hal tersebut ditandai dengan ovarium akan menghasilkan sel telur atau yang kita kenal dengan ovum dan pada bagian endometrium (dinding rahim) mengalami penebalan sebagai persiapan tempat perkembangan janin. Penebalan dinding rahim tersebut berisi pembuluh darah. Jika proses kehamilan tidak berlangsung, maka dinding rahim akan luruh dan keluar

bersamaan dengan darah melewati vagina yang kita kenal dengan "Menstruasi" (Mawardika, 2023).

Pada saat menjelang menstruasi, dimana kelenjar endokrin pada perempuan akan menghasilkan suatu hormon yang kita kenal dengan prostaglandin. Hormon tersebut memiliki fungsi yaitu membuat dinding Rahim menjadi berkontraksi dan pembuluh darah disekitarnya mengalami penyempitan yang kita kenal dengan kontriksi. Suatu kondisi pembuluh darah yang mengalami kontriksi akan menimbulkan iskemik pada jaringan. Intensitas terjadinya kontraksi berbeda-beda pada setiap perempuan dan jika kondisi tersebut terjadi secara berlebihan akan menimbulkan nyeri atau perasaan yang tidak nyaman pada perut bagian bawah menjalar sampai ke pinggang. Hal tersebut dirasakan saat menstruasi. Perasaan yang tidak nyaman yang dialami Perempuan tersebut ditambah dengan kondisi Dimana hormon prostaglandin akan merangsang saraf nyeri di rahim sehingga meningkatkan intensitas nyeri (Mawardika & Aniroh, 2022)

B. Usia Menstruasi

Seorang Perempuan, ketika menstruasi datang pertama kali berada pada rentang usia yang bervariasi, ebagian besar ketika mereka menginjak usia remaja yakni pada rentang usia 10 sampai 18 tahun. Tetapi ada pula yang mengalami menstruasi pertama lebih awal atau berada kueang dari rentang usia tersebut. Pada masa ini terdapat kecenderungan bahwa seorang perempuan mengalami menstruasi pertama kali pada usia yang lebih belia. Perempuan yang belum sama sekali mengalami menstruasi pada rentang tersebut sering kita kenal dengan istilah *amenorrhea primer*, sedangkan seorang perempuan yang

mengalami menstruasi sebelum usia 8 tahun kita kenal dengan istilah menstruasi *precok* (Ramathuba, 2015). Usia terjadinya menstruasi pertama kali menurut Marmi (2023) dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Menarche cepat: usia kurang dari 11 tahun
2. Menarche normal: usia 11 sampai 13 tahun
3. Menarche lambat: usia lebih dari 13 t

C. Tanda dan Gejala Menstruasi

Seorang perempuan yang sudah menginjak fase pubertas akan mengalami proses menstruasi diikuti pertumbuhan fisik yang ditandai adanya pertumbuhan payudara, pertumbuhan rambut pada daerah kemaluan dan pada bagian aksila, serta melebarnya area pinggul. Manifestasi klinis menjelang menstruasi datang akan timbul rasa nyeri di payudara, sakit pinggang, adanya perasaan tidak nyaman seperti pegal linu serta perasaan seperti kembung, mulai timbulnya jerawat di wajah karena adanya peningkatan lemak, memiliki perasaan lebih sensitif, dan mengalami perubahan emosional yang tidak menentu karena disebabkan oleh produksi hormon yang dihasilkan oleh seorang perempuan (Fitria & Mawardika, 2023).

D. Fisiologis Menstruasi

Peningkatan *Follicle Stimulating Hormone* (FSH) dan *Luteinizing Hormone* (LH) akan merangsang sel target yang terdapat pada bagian ovarium sehingga mengakibatkan terjadinya proses menstruasi. FSH dan LH melakukan kombinasi atau bersatu dengan reseptor untuk menaikkan laju kecepatan sekresi, pertumbuhan dan proliferasi sel. Proses stimulasi tersebut dihasilkan oleh pengaktifan sistem *second messenger adenosine-*

monophosphate cyclic yang berada di dalam sitoplasma sel ovarium untuk merangsang ovarium agar memproduksi hormon esterogen dan progesterone. Esterogen dan progesterone akan merangsang rahim dan kelenjar payudara agar bersiap ketika terjadi proses ovarium yang menghasilkan ovum atau yang sering kita kenal dengan ovulasi. Hasil dari proses ovulasi berupa ovum yang tidak dibuahi akan luruh menjadi menstruasi. Menstruasi yang pertama ini biasa disebut *menarche* (Aniroh & Mawardika, 2022).

E. Siklus Menstruasi

Seorang perempuan, sebagian besar akan mengalami proses menstruasi sebulan sekali. Jarak menstruasi yang terjadi saat ini dengan menstruasi yang terjadi akan datang memiliki siklus dengan rentang rata-rata berkisar 28 hari, sedangkan lama menstruasi pada seorang perempuan memiliki masa yang berbeda-beda, sebagian besar biasanya terjadi dalam rentang selama 3-7 hari (Andayani, 2015).

F. Faktor yang Mempengaruhi Menstruasi

1. Status gizi

Tingkat kematangan seksual pada seorang perempuan salah satunya akan dipengaruhi oleh status gizi sehingga akan berpengaruh pada usia *menarche*. Tingkat kematangan seksual akan berhubungan dengan Indeks Masa Tubuh (IMT) yang erat kaitannya dengan status gizi. Sebagian besar perempuan cenderung Indeks Masa Tubuh (IMT) yang lebih tinggi begitu pula sebaliknya pada Perempuan dengan IMT yang lebih kecil pada usia yang sama akan cenderung memiliki kematangan seksual yang lebih lambat. Hal tersebut

disebabkan karena status gizi dengan kategori berlebih atau yang sering kita kenal dengan *overweight* (OW). Hal tersebut dikarenakan oleh adanya paparan hormon estrogen dan progesteron yang tinggi, Peningkatan kedua hormon tersebut ini akibat adanya pola konsumsi makanan dengan kadar lemak yang tinggi (Putra,et.al., 2016).

2. Berat badan lahir

Terdapat korelasi antara usia menarche dan berat badan lahir, Hal tersebut dapat disebabkan oleh pembahasan sebelumnya yaitu status gizi selama ibu mengalami proses kehamilan. Asupan gizi Ketika ibu hamil dapat dicerminkan dari berat badan lahir pada anak, hal tersebut akan membawa pengaruh pada tahap pertumbuhan dan perkembangan badan anak sehingga berakibat pada usia *menarche* seorang perempuan (Putra et al., 2016).

3. Sosial ekonomi

Status sosial ekonomi pada suatu keluarga memiliki pengaruh yang cukup penting dalam usia *menarche* yang dialami oleh seorang perempuan, Status sosial ekonomi pada suatu keluarga dapat membawa pengaruh keluarga dalam hal ketersediaan pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga yang mempunyai pemenuhan cukup gizi. Remaja perempuan dengan status social ekonomi yang cukup tinggi cenderung akan lebih memperoleh gizi dan nutrisi yang tercukupi bahkan lebih sehingga usia *menarche* akan lebih cepat (Sari, 2021).

4. Aktifitas fisik

Seorang Perempuan yang melakukan aktifitas secara berlebihan seperti melakukan latihan fisik yang berlebihan mampu mengakibatkan kehilangan massa tubuh

bersih, hal tersebut disebabkan oleh beberapa factor diantaranya adalah karena kehilangan nafsu makan dan kelelahan. Selain itu, latihan fisik yang berat dapat memperlambat terjadinya menstruasi (Sinaga, 2015). Sebaliknya remaja dengan aktifitas fisik yang kurang, seperti lebih banyak menghabiskan waktu untuk tidur-tiduran diatas Kasur, menonton TV, malas bergerak cenderung akan mengalami proses menstruasi lebih awal (Andayani, 2015).

5. Rangsangan audio visual

Faktor penyebab datangnya *menarche* lebih dini juga disebabkan karena ada stimulasi dari rangsangan audio visual, rangsangan tersebut bisa timbul dari percakapan yang dilakukan oleh remaja Perempuan. Bisa juga disebabkan karena adanya tontonan dari film-film atau internet yang berlabel dewasa, mengumbar sensualitas dan bersifat vulgar. Stimulasi ini diterima oleh indra kita pada khususnya adalah indra penglihatan (mata) dan indra pendengaran (telinga) sehingga dapat mempengaruhi fungsi organ reproduksi untuk lebih cepat matang dibandingkan dengan yang lainnya, Hal tersebut berkaitan dengan kecepatan usia pubertas remaja sehingga mengakibatkan remaja putri mengalami proses menstruasi yang lebih cepat (Sari, 2021).

G. Persiapan Menghadapi Menstruasi

1. Mengenal gejala *menarche*

Menurut Proverawati & Misaroh (2017), terdapat beberapa tanda dan gejala yang akan datang bersamaan dengan proses menstruasi timbul, baik sebelum ataupun selama proses menstruasi terjadi, yaitu timbulnya perasaan yang tidak nyaman. Hal tersebut disebabkan

karena selama proses menstruasi terjadi volume air yang terdapat dalam tubuh akan berkurang karena adanya kondisi kehilangan darah saat menstruasi. Manifestasi klinis lain yang dirasakan yaitu munculnya sakit kepala, perasaan pegal yang terjadi di kaki dan pinggang, timbulnya kram perut, dan timbulnya sakit perut. Sebelum proses menstruasi berlangsung akan terjadi beberapa perubahan emosional, seperti munculnya perasaan sedih, suntuk, marah (secara garis besar pada masa ini remaja putri lebih mudah sensitif dibandingkan sebelumnya) yang disebabkan karena adanya pelepasan hormon.

2. Pemenuhan asupan nutrisi

Salah satu hal yang harus dipersiapkan Ketika proses menstruasi datang adalah dengan adanya asupan nutrisi yang baik dan seimbang. Asupan nutrisi yang baik dan seimbang diantaranya adalah:

a. Zat besi

Zat besi adalah komponen mineral penting untuk kondisi kesehatan darah. Kondisi zat besi yang kurang dapat mengakibatkan timbulnya situasi kekurangan sel darah merah atau eritrosit terutama pada saat terjadi proses menstruasi. Suatu tindakan preventif yang harus dilakukan untuk mencegah hal tersebut adalah makan-makanan yang mengandung komponen zat besi tinggi, seperti brokoli, buncis, manga, buah bit, berry, labu, papaya, biji wijen, ubi, selada air, kedelai, dan kacang-kacangan.

b. Magnesium

Ketika kondisi tubuh kekurangan magnesium di dalam sel akan membawa dampak pada timbulnya *Pre Menstrual Sindrom* (PMS). Konsumsi makanan yang mengandung magnesium sangat disarankan sebagai

Upaya pencegahan timbulnya PMS. Makanan yang tinggi magnesium salah satu diantaranya adalah seperti, apel, pir, bayam kubis, paprika, rumput laut, dan ubi.

c. Kalsium

Kalsium memiliki fungsi yang sangat penting yaitu mengurangi timbulnya rasa kram dan kejang akibat menstruasi. Kandungan kalsium utama banyak terdapat pada bahan makanan seperti kacang-kacangan, susu nonfat, keju, sayuran hijau, ikan kering, serelia, tahu dan tempe.

d. Rendah garam

Suatu implementasi guna mencegah permasalahan yang menyertai menstruasi seperti PMS, salah satunya bisa dengan cara makan makanan yang mengandung natrium, seperti sayur dan buah-buahan segar. Hindari makanan yang mengandung natrium yang tinggi seperti *fast food* atau makanan cepat saji. Minum air mineral yang cukup sangat dianjurkan untuk membantu tubuh agar tidak mengalami dehidrasi.

e. Rendah lemak

Gejala yang menyertai menstruasi menjadi tidak nyaman, salah satunya dengan mengonsumsi makanan olahan yang dibuat dengan kadar gula yang tinggi dan makanan mengandung kadar lemak yang tinggi. Hal tersebut dapat berkontribusi pada munculnya gejala menstruasi yang tidak nyaman, perasaan kembung, dan kram. Menghindari makanan cepat saji atau *fast food* mampu mencegah terjadinya berbagai gangguan yang menyertai menstruasi tersebut. Selain itu, hindari minuman yang mengandung kafein seperti, teh, kopi, dan coke serta

makanan yang memiliki kandungan lemak jenuh seperti makanan yang digoreng, daging merah, dan mentega.

3. Perawatan diri saat menstruasi

Suatu Intervensi yang dilakukan ketika remaja mengalami menstruasi yaitu menjaga kebersihan terutama pada organewanitaan selama masa menstruasi berlangsung dengan mengganti pembalut minimal dua kali sehari, hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi perkembangbiakan bakteri yang bersifat merugikan. Mulai jeli dalam menggunakan pembalut, gunakan pembalut dengan bahan halus dan lembut, bersifat mudah menyerap dengan baik, tidak mengandung bahan yang bisa menyebabkan alergi seperti gel atau parfum. Selain yang disebutkan diatas remaja lebih disarankan untuk menjaga kebersihan vagina, organ reproduksi terutama vagina karena kuman ataupun bakteri mudah sekali masuk dan dapat beresiko menimbulkan penyakit pada organ reproduksi perempuan.

4. Mengurangi nyeri saat menstruasi

Nyeri menstruasi merupakan nyeri yang muncul sebelum dan selama proses menstruasi berlangsung yang terjadi karena adanya kontraksi otot uterus akibat peluruhan dinding rahim (endometrium). Rasa Nyeri yang dialami sering disertai dengan munculnya gejala lain seperti mual, muntal, cenderung sensitive dan lebih cepat marah, serta pusing. Nyeri menstruasi disebutsering kita kenal dengan istilah *dismenorea*. Jika terjadi nyeri saat menstruasi berlangsung kita dapat mengatasi dengan melakukan beberapa intervensi yaitu:

a. Masase

Masase sering kita kenal dengan suatu intervensi berupa pijatan lembut pada bagian tubuh yang terasa tidak nyaman dengan menggunakan tangan. Berdasarkan hasil penelitian Mawardika, dkk. (2022) didapatkan nilai signifikansi $0,003 < 0,05$ yang berarti terdapat perbedaan bermakna pada tingkat pengetahuan antara sebelum dan setelah edukasi tentang program TATO (*Tapping Touch*) untuk mengatasi remaja putri dengan nyeri dismenorea. Hal tersebut menunjukkan bahwa salah satu tehnik masase mampu menurunkan derajat nyeri dismenore. Hasil penelitian lain menunjukkan tentang Sweddisch Masase Terapy (DIMATA) mampu menurunkan derajat nyeri disminore dengan nilai $p \text{ value } (0,02) < \text{nilai } \alpha (0,05)$ (Mawardika dkk, 2023).

b. Kompres panas

Kompres panas dapat diartikan sebagai kompres air hangat dengan suhu air $43-46^{\circ}\text{C}$ dengan bertujuan untuk mengurangi ketegangan otot dan menurunkan derajat nyeri akibat kekakuan.

c. Kompres dingin

Sejalan dengan kompres hangat pada pembahasan sebelumnya, kompres dingin mampu menurunkan ketegangan otot serta memperlambat transmisi nyeri dan impuls-implus lainnya lewat neuron sensorik.

d. Teknik distraksi

Teknik distraksi merupakan teknik pengalihan dari fokus perhatian terhadap nyeri ke rangsangan yang lain sehingga pikiran kita tidak lagi terfokus pada nyeri yang dirasakan namun pada objek baru yang lebih menyenangkan, sebagai contoh menonton televisi, mendengarkan cerita yang menentramkan hati,

mendengarkan musik yang digemari, serta melakukan teknik relaksasi nafas dalam (Mualifah, 2019). Namun apabila nyeri terasa berlebihan cara tersebut kurang efektif dalam mengatasi nyeri dan harus segera minum obat yang berasal dari golongan analgesic dan harus segera dibawa ke dokter untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pemberian vitamin dengan jenis tertentu seperti B1, B6, dan B12 dapat menjadi pilihan untuk seseorang yang menderita keluhan sakit pada saat menstruasi namun harus diminum sesuai dosis yang dianjurkan (Proverawati & Misaroh, 2017).

e. Menjaga aktivitas fisik

Gangguan rasa nyaman seperti nyeri yang dirasa saat menstruasi akan meningkat dengan kurangnya aktivitas karena fokus pusat kita hanya pada kondisi nyeri tersebut dan kurangnya olahraga selama menstruasi, hal ini dapat menyebabkan sirkulasi darah dan oksigen menjadi turun. Dampak yang terjadi akibat aliran darah dan oksigen ke uterus menurun dapat menyebabkan timbulnya nyeri haid. Aktivitas yang teratur dan cukup seperti berolahraga setiap hari dapat menjadi obat penenang alami yang diproduksi untuk menurunkan tingkat nyeri diseminore dan menimbulkan efek berupa rasa nyaman. Olahraga ataupun aktifitas yang dapat dilakukan saat menstruasi sebagai upaya memperlancar sirkulasi darah adalah jalan kaki santai, yoga dan pilates, hal tersebut harus dilakukan secara teratur atau intensif (Wibawati, 2021).

5. Mekanisme koping saat menstruasi

Pada saat remaja terjadi perubahan secara psikologis seperti emosi yang tidak stabil sehingga dapat menyebabkan remaja dalam memecahkan suatu masalah

yang dihadapi, hal tersebut yang akan menyebabkan remaja putri berfikir negatif terhadap proses menstruasi. Jika remaja sering memiliki konsep pikir yang negatif, akan menstimulasi terjadinya stres. Stres yang berkelanjutan atau dalam jangka panjang dapat menyebabkan kondisi depresi apabila *sense of control* atau kemampuan mengatasi stres kurang stabil dan kurang baik (Setiawati, 2015).

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mencegah stres adalah dengan pemanfaatan mekanisme koping dengan baik misalnya istirahat dan tidur dengan cukup, mengatur diet dan nutrisi yang seimbang, berolahraga secara teratur, mengatur dan menjaga berat badan secara ideal, mengatur waktu yang tepat, dan berbagai terapi psikofarmaka, terapi religious dan terapi somatik (Mesarini & Astuti, 2023).

BAB 4

MENSTRUAL HYGIENE MANAGEMENT

Salah satu masalah yang menjadi fokus perhatian dan dianggap sangat penting pada masa remaja adalah permasalahan kesehatan reproduksi. Kelompok remaja menjadi perhatian karena remaja termasuk dalam kategori kelompok rentan dengan jumlah persebaran di kalangan remaja cukup besar dan mempunyai risiko terhadap timbulnya berbagai masalah kesehatan reproduksi. Seorang remaja harus dipersiapkan secara matang baik dari segi pengetahuan, sikap, dan perilakunya ke arah pencapaian fungsi reproduksi yang sehat (Sumpter and B. Toronde, 2023).

Ketika seorang remaja putri sudah mulai memasuki masa pubertas yang dialami dengan dimulainya proses menstruasi, hal utama yang menjadi focus perhatian adalah kebersihan pada saat menstruasi atau yang sering dikenal dengan *Menstrual Hygiene Management* (MHM). Hal tersebut disebabkan oleh pembuluh darah pada rahim yang sangat mudah terinfeksi ketika terjadi menstruasi karenainvasi bakteri dan kuman sehingga menimbulkan penyakit pada organ reproduksi (Aniroh, 2024).

Salah satu keluhan yang dirasakan pada organ reproduksi yang sering terjadi Ketika terjadi menstruasi adalah *Pruiritas Vulvae (PV)* yaitu ditandai dengan adanya sensasi rasa gatal parah yang muncul dari organ genitalia perempuan (Varghese, P. J. Prakash, and L. Viswanath, 2019). Pruiritas vulvae disebabkan karena adanya invasi jamur, virus dan bakteri, yang muncul

karena buruknya Personal Hygiene yang buruk. Hal tersebut sejalan dengan penelitian tentang penyebab Pruritis Vulvae adalah karena buruknya Hygiene Menstruasi (44%), karena alergen dan produk kewanitaan yang tidak terjamin keamanannya (30%), serta karena adanya kelainan patologik pada vulva (26%) (Varghese, P. J. Prakash, and L. Viswanath, 2019). Selain itu akibat menstrual Hygiene yang buruk dapat menjadi salah satu munculnya penyakit kanker. Penyakit kanker merupakan salah satu penyebab utama *silent killer* di seluruh dunia. Menurut data Global Burden Cancer (Globocan), International Agency for Research on Cancer (IARC), disebutkan bahwa pada tahun 2022 terdapat 14.067.894 kasus baru kanker dan 8.201.575 kematian akibat kanker di seluruh dunia. Berdasarkan laporan yang diperoleh dari Globocan 2022 diperkirakan bahwa kejadian kanker yang terjadi di Indonesia sebesar 134 per 100.000 penduduk. Sedangkan berdasarkan hasil wawancara Riskesdas 2022 didapatkan prevalensi penderita kanker di Indonesia sebesar 1,4 per 1000 penduduk. Penyakit yang diderita oleh perempuan yaitu kanker serviks dan kanker payudara merupakan penyakit kanker dengan prevalensi tertinggi di Indonesia pada tahun 2013, yaitu kanker serviks sebesar 0,8 per 1000 penduduk dan kanker payudara sebesar 0,5 per 1000 penduduk. Personal Hygiene yang baik diperlukan agar terhindar dari sakit atau penyakit yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi (Sumpter and B. Toronde, 2023)

A. Pengertian Menstrual Hygiene Management

Hygiene merupakan sebuah ilmu dalam lingkup kesehatan tentang bagaimana cara seseorang untuk melakukan perawatan diri pada individu agar dapat memelihara kesehatannya dengan baik dan benar atau disebut juga dengan kebersihan perorangan (*personal*

hygiene). *Personal hygiene* berasal dari bahasa asing bahasa Yunani, dimana *personal* yang memiliki arti perorangan dan *hygiene* memiliki arti sehat. *Personal hygiene* dapat diartikan sebagai kebersihan perorangan. *Personal hygiene* adalah suatu merupakan suatu tindakan untuk menjaga kesehatan dan kebersihan seseorang untuk kesejahteraan fisik dan psikis. Perilaku pemeliharaan *hygiene* perorangan diperlukan untuk kenyamanan individu, keamanan, dan kesehatan (Fitria & Mawardika, 2023). Selayaknya seperti pada orang sehat yang mampu mencukupi atau meningkatkan status kesehatannya secara mandiri, pada orang sakit dalam usaha pemenuhan kesehatannya membutuhkan bantuan tenaga kesehatan dan menjadi sebuah tantangan tersendiri (Sumpter and B. Toronde, 2023).

Menstrual Hygiene Management merupakan komponen *hygiene* perorangan yang menduduki posisi penting dalam perilaku kesehatan yang dilakukan oleh seorang perempuan khususnya kebersihan pada organ reproduksinya saat mengalami menstruasi. Manajemen *hygiene* menstruasi merupakan suatu dasar dalam pengelolaan diri khusus organ genitalia saat menstruasi agar mampu melakukan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari terasa nyaman dan tanpa gangguan yang berarti seperti pergi ke sekolah, bekerja, dan lain-lain (Kaur, K. Kaur, and R. Kaur, 2018).

Usaha yang dilakukan untuk menjaga kesehatan dan kebersihan organewanitaan diantaranya adalah tata cara penggunaan pembalut saat menstruasi, idealnya penggunaan pembalut selama menstruasi harus diganti secara teratur setiap 3-4 jam sekali atau 4 sampai 5 kali sehari terutama saat darah menstruasi keluar dengan jumlah yang banyak pada 2-3 hari pertama saat menstruasi. Tindakan

Menstrual Hygiene yang lain dan hendak diperhatikan adalah saat setelah cebok, vagina atau organ genitalia harus dikeringkan menggunakan tisu atau handuk agar tidak lembab. Karena area yang lembab memungkinkan invasi bakteri dan kuman masuk kedalam vagina. Selain cara yang disebutkan diatas perlu diperhatikan dalam memilih celana dalam hendaknya menggunakan bahan yang terbuat dari kain yang sifatnya mudah menyerap keringat (Michael,et. al, 2020).

B. Tujuan dan Manfaat Menstrual Hygiene

Tujuan dan manfaat perawatan diri pada area genetalia perempuan saat menstruasi datang, yaitu:

1. Meningkatkan derajat status kesehatan seorang perempuan
2. Kebersihan diri seorang Perempuan dapat terjaga
3. Memperbaiki perilaku personal hygiene yang kurang baik atau kurang sesuai
4. Mencegah masuknya bakteri, virus dan kuman yang dapat menyebabkan penyakit
5. Menciptakan keindahan
6. Meningkatkan rasa percaya diri pada seorang perempuan.

Jika seorang remaja putri melaksanakan menstrual hygiene yang baik dan benar pada saat setiap menstruasi datang maka akan terhindar dari kanker rahim atau sebagai perwujudan saran preventif terhadap suatu penyakit yang erat kaitannya dengan organ reproduksi wanita, lebih merasa nyaman ketika melakukan aktivitas sehari-hari, lebih merasa percaya diri, menjadi lebih bersemangat dan tidak merasa malas lagi, tidak dijauhi teman-teman karena bau badan yang tidak sedap, dan lebih memahami kebenaran serta tidak

mempercayai mitos-mitos yang beredar di masyarakat (Chinyama,2019).

C. Menstrual Hygiene Management

Menurut E. R. Mac Rae, T. Clasen, M. Dasmohapatra, and B. A. Caruso (2019), beberapa aspek penting yang harus diperhatikan dan dikerjakan oleh remaja putri dalam menjaga kesehatan organ reproduksinya, yaitu:

1. Selama menstruasi berlangsung wajib menggunakan pembalut untuk mempermudah penyerapan darah yang keluar dari vagina. Bila tidak ada pembalut disarankan untuk menggunakan tampon yang berasal dari kain, namun harus dibersihkan karena akan dipakai lagi setelah kering yang berbeda karakteristiknya dengan pembalut yang memiliki cirikhas penggunaan hanya sekali pakai atau tidak bisa *reuse* atau dimanfaatkan kembali.
2. Pada saat menggunakan pembalut ada beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya adalah pilih pembalut yang berbahan halus dan lembut agar tiak mudah timbul iritasi pada area genital. Pilih pembalut yang mampu menyerap dengan baik. Pembalut harus diganti pemakaiannya minimal dua kali sehari selama menstruasi atau minimal 3-4 jam dalam sehari. Jangan membiarkan pembalut tidak diganti seharian sehingga lengket. Pembalut yang telah dipakai dibersihkan dengan benar sampai bersih dengan mencucinya dibawah air mengalir sampai tidak tersisa lagi darah dan kemudian dibungkus plastik/ kertas bekas baru setelah itu dibuang ke tempat sampah.
3. Secara rutin dan teratur mencatat siklus menstruasi setiap bulannya mulai dari awal sampai akhir dan melakukan pengecekan pada kondisi tubuh saat menstruasi untuk

mendeteksi terdapat gangguan kesehatan saat menstruasi berlangsung atau tidak.

4. Mengatur jadwal tidur, karena istirahat yang cukup dapat meminimalisir timbulnya gejala PMS saat menstruasi berlangsung.
5. Dianjurkan untuk lebih banyak mengonsumsi makanan kaya zat besi dan susu berkalsium tinggi saat menstruasi berlangsung.
6. Melakukan aktifitas fisik ringan dan berolahraga secara teratur untuk membantu mengatasi permasalahan nyeri haid yang timbul saat menstruasi tiba.
7. Melakukan penggantian celana dalam 2-3 kali sehari, agar celana tidak lembab dan terhindar dari bakteri dan kuman yang masuk dalam organ genitalia.
8. Menjaga kebersihan vagina melalui tindakan membilas organewanitaan dengan air bersih yang mengalir dari arah depan ke belakang. Sebelum cebok diawali terlebih dahulu dengan mencuci kedua tangan terlebih dahulu, dan agar tidak melukai organ genetalia pastikan kuku tidak panjang.
9. Menjaga organ reproduksi supaya tidak lembab dengan mengeringkan area kewanitaandengan tisu setelah cebok dan mengganti celana dalam secara berkala agar bakteri dan kuman tidak masuk kedalam vagina.
10. Memakai celana dalam tidak terlalu ketat dan utamakan dengan menggunakan bahan yang bersifat mudah menyerap keringat.
11. Mandi secara teratur dua kali sehari, minimal 1 kali sehari dengan air bersih lebih baik menggunakan air hangat agar peredaran darah menjadi lancar.
12. Membuang sampah pembalut dengan membungkusnya dengan menggunakan plastik gelap lalu baru dibuang ke

tempat sampah. Jangan sembarangan ketika membuang sampah karena akan menyebabkan penyumbatan pada saluran pembuangan.

Hal tersebut didukung hasil penelitian Aniroh dan Mawardika (2022), menyatakan bahwa Ada perbedaan yang signifikan pengetahuan tentang *Menstrual Higyene Management* pada siswi SMP An Nur Ungaran yang diberikan pendidikan kesehatan dengan media video animasi dan *booklet print* dengan t hitung $(-8,353) < t$ tabel $(-1,734)$ dan nilai p -value $(0,000) < \alpha$ $(0,05)$. Begitu juga ada perbedaan yang signifikan sikap tentang *Menstrual Higyene Management* pada siswi SMP An Nur Ungaran yang diberikan pendidikan kesehatan dengan media video animasi dan *booklet print* dengan t hitung $(-7,242) < t$ tabel $(-1,734)$ dan nilai p -value $(0,000) < \alpha$ $(0,05)$.

Menstrual Hygiene Management dapat ditingkatkan melalui intervensi berupa pendidikan kesehatan, hal tersebut sesuai dengan penelitian Karminingtyas, et.al (2023), tentang Edukasi Kesehatan Menstrual Hygiene Dan Penatalaksanaan *Premenstrual Syndrome* didapatkan nilai p value $(0,004) < \alpha$ $(0,05)$ yang berarti terdapat perbedaan yang bermakna terkait dengan tingkat pengetahuan sebelum dan setelah edukasi menstrual hygiene dan premenstrual syndrome.

D. Dampak Menstrual Hygiene yang buruk

Proses menstruasi merupakan merupakan pengeluaran darah kotor, hal tersebut berpotensi timbulnya infeksi pada organ genitalia yang disebabkan karenajika kurang menjaga kebersihan (Yusuf, 2022). Sedangkan, apabila remaja putri kurang adanya kesadaran dalam menjaga kebersihan organ

genetaliaanya , tidak mampu menjaga penampilan serta kesehatan selama menstruasi, akan beresiko terkena kanker rahim, dan keputihan, berkurangnya aktivitas yang dilakukan saat menstruasi karena adanya rasa malas, timbulnya perasaan kurang percaya diri, munculnya rasa percaya akan mitos-mitos yang berkaitan dengan menstruasi yang beredar di masyarakat, karena bau badan amis menyebabkan dijauhi orang lain dalam pergaulan, dan lain sebagainya (Sumpter and B. Toronde, 2023).

Hasil penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa kurangnya perilaku berkaitan dengan perawatan diri yang berfokus pada organ reproduksi saat menstruasi dapat menyebabkan berbagai penyakit misalnya kanker rahim (Aniroh & Mawardika, 2024). Berdasarkan data dari data kesehatan Dunia (WHO), prevalensi kejadian kanker serviks menduduki nomor dua terbanyak setelah kanker payudara pada perempuan dengan rentang usia 15 – 45 tahun. Tidak kurang dari 500.000 kasus baru terjadi setiap tahunnya yang disertai dengan kematian 280.000 penderita (Belayneh & Mekuriaw, 2019).

Kanker serviks memang membutuhkan perhatian khusus karena setiap dua menit seorang perempuan diduga meninggal akibat kanker serviks. Terdapat 1,3 milyar perempuan dengan usia diatas 13 tahun di wilayah Asia Pasifik, Timur Tengah dan sekitarnya memiliki risiko terkena kanker serviks. Badan Kesehatan Dunia memprediksi kejadian kanker serviks terjadi lebih dari 265.000 kasus dengan jumlah kematian sebanyak 140.000 penderita setiap tahun terjadi di wilayah tersebut. Menurut data Globocan tahun 2017, terdapat lebih dari 40.000 kasus baru dengan kejadian kanker serviks dengan jumlah sekitar 22.000

kematian karenanya pada wanita di Asia Tenggara (Kaur, K. Kaur, and R. Kaur, 2018).

Indonesia merupakan negara yang berada pada peringkat pertama untuk kasus perempuan dengan penderita kanker mulut rahim (serviks) sedunia, sedangkan data yang berasal dari Yayasan Kanker Indonesia, bahwa penyakit kanker leher rahim (serviks) mengakibatkan korban meninggal dunia sekurangnya 555 wanita perharinya dan 200.000 wanita per tahunnya. Berdasarkan beberapa hasil penelitian disebutkan bahwa kanker serviks disebabkan oleh virus *Human Papilloma Virus* (HPV) yang muncul antara lain karena perilaku sering berganti-ganti pasangan seks dan perilaku yang menstabil hygiene management yang buruk pada saat menstruasi (Chinyama, 2019).

Virus dapat hidup di daerah yang lembab maka dari itu sangat dianjurkan mengeringkan area kewanita setelah cebok untuk mencegah invasi virus bakteri maupun kuman ke dalam vagina. HPV secara tepatnya dapat hidup dan berkembang dalam cairan vagina yang kita dapati oleh penderita keputihan (leukore). Jika kondisi ini terjadi secara berkelanjutan, virus ini mampu mengakibatkan kanker rahim atau yang sering kita kenal dengan kanker serviks. Kondisi ini biasanya ditandai dengan munculnya cairan keputihan dengan jumlah yang banyak disertai dengan bau yang tidak sedap dan munculnya perdarahan yang keluar dari area genitalia. Namun tidak semua kejadian kanker menimbulkan tanda dan gejala, sebagian kejadian kanker yang muncul itu tidak menampakkan tanda dan gejala seperti yang disebutkan diatas. Salah satu penyebab utama kanker serviks di Indonesia adalah karena menstrual hygiene manajemen yang buruk (Michael, et al, 2020).

Oleh sebab itu, menjaga kebersihan organ reproduksi menjadi point penting terutama pada bagian vagina pada saat menstruasi terjadi. Jika seorang perempuan tidak menjaga kebersihan organ genetaliaanya, akan menimbulkan mikroorganisme dengan jumlah berlebih sehingga dapat mengganggu fungsi organ reproduksi (Kim & Choi, 2019).

BAB 5

DUKUNGAN SOSIAL TEMAN SEBAYA

A. Dukungan Sosial

Dukungan sosial menurut Sarafino menjelaskan dukungan sosial mengacu pada memberikan kenyamanan pada orang lain, merawatnya, atau menghargainya. Pendapat senada juga diungkapkan oleh Sarason yang menyatakan bahwa dukungan sosial adalah adanya interaksi interpersonal yang ditunjukkan dengan memberikan bantuan pada individu lain, dimana bantuan itu umumnya diperoleh dari orang yang berarti bagi individu yang bersangkutan. Dukungan sosial dapat berupa pemberian informasi bantuan tingkah laku ataupun materi yang dapat dari hubungan sosial akrab yang dapat membuat individu merasa diperhatikan, bernilai dan dicintai. Pierce mendefinisikan dukungan sosial sebagai sumber emosional informasional atau pendampingan setiap permasalahan dan krisis yang terjadi sehari-hari dalam kehidupan. Gottlieb dalam (Hanapi, dkk,2018),menyatakan dukungan sosial terdiri dari informasi atau nasehat verbal maupun non verbal, bantuan nyata atau tindakan yang didapat karena kehadiran orang lain dan mempunyai manfaat emosional atau efek perilaku bagi pihak penerima.

Dukungan sosial akan tercipta dari munculnya kelompok sosial,yaitu suatu himpunan manusia yang saling berhubungan timbal balik antara satu sama lain dalam

sebuah struktur sesuai dengan pola yang telah matang. Sekumpulan orang akan disebut sebagai kelompok sosial jika telah memenuhi 3 syarat utama, sebagai berikut (Margiyanti,2022):

1. Setiap anggota kelompok menyadari bahwa ia merupakan bagian dari kelompoknya.
2. Setiap anggota memiliki kesamaan latar belakang atau karakteristik
3. Terdapat struktur, norma, dan pola perilaku

Sedangkan menurut Soekanto dalam (Indrawan,2020) menyatakan bahwa kelompok sosial tidak bisa dipisahkan dari 5 persyaratan di dalamnya, yaitu:

1. Setiap anggota yang bergabung di dalamnya menyadari dirinya adalah bagian dari kelompok tersebut
2. Di dalam kelompok tersebut ditemukan hubungan timbale balik diantara anggota-anggotanya
3. Semua anggota memiliki faktor penghubung yang sama, contohnya kesamaan nasib, kesamaan kepentingan, kesamaan pandangan politik, dan sebagainya, dengan adanya berbagai kesamaan inilah yang membuat ikatan antar-individu pada kelompok sosial semakin erat
4. Memiliki struktur, kaidah, dan pola perilaku, dimana struktur yang terdapat di suatu kelompok sosial memungkinkan setiap anggota memiliki peran, fungsi dan hierarki yang jelas
5. Memiliki sistem dan berproses
6. Setiap kelompok sosial mempunyai tujuan sama yang kemudian membentuk norma-norma atau peraturan yang harus ditaati demi mencapai tujuan yang diinginkan kelompok tersebut

Menurut Tuckman dalam (Anwar,2022) terdapat 5 tahap pembentukan dan perkembangan kelompok sosial yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Tahap Pembentukan (*Forming*)

Dalam tahap pembentukan ini, para anggota mulai mempelajari setiap tugas yang diberikan serta berkenalan dengan anggota lainnya. Tahap *forming* ini identik dengan ketidakpastian karena para anggota kelompok masih tidak memahami secara jelas terkait dengan tujuan dan *objective* kelompok, merasa bingung, menyembunyikan perasaan serta kurangnya keterlibatan dalam suatu kelompok.

2. Tahap Timbulnya Konflik (*Storming*)

Tahap *storming* ditandai dengan timbulnya kemarahan, rasa menyebalkan, ketidaknyamanan, konflik atau adu pendapat dan kegagalan. Hal itu disebabkan karena para anggota mulai bekerja, akan tetapi mereka cenderung mempertahankan pendapat mereka sendiri dan menolak segala bentuk batasan yang ditetapkan oleh kelompok terhadap individu mereka.

3. Tahap Normalisasi (*Norming*)

Tahap ini merupakan tahap terbentuknya suatu hubungan yang lebih dekat antar anggota kelompok, tahap untuk menetapkan aturan-aturan serta menemukan cara komunikasi yang tepat agar dapat membantu mereka dalam mencapai tujuan. Tahap *norming* ditandai dengan adanya peninjauan ulang dan penjelasan terkait dengan tujuan kelompok, muncul persahabatan dan kerjasama antar anggota kelompok, mulai dapat mendengarkan pendapat dari anggota lain, serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan.

4. Tahap Berkinerja (*Performing*)

Dalam tahap ini semua anggota kelompok sudah mampu bekerja dan menjalankan fungsinya secara penuh. Selain itu, semua anggota juga memiliki kebersamaan, rasa percaya diri, kreatif, inisiatif, dan semangat yang tinggi.

5. Tahap Pembubaran (*Adjourning*)

Tahap *adjourning* ini khusus untuk kelompok kerja yang sifatnya hanya sementara. Hal ini terjadi karena apabila ada suatu proyek atau permasalahan sudah berhasil dituntaskan, maka kelompok kerja tersebut akan langsung dibubarkan.

Dukungan sosial dapat diberikan secara langsung dan berwujud, memberikan rasa aman dan nyaman, memberikan penghargaan yang positif, dan memberikan penilaian berupa nasihat, saran ataupun umpan balik mengenai apa yang sebaiknya dilakukan oleh seseorang akan membentuk dukungan sosial Cohen & Syme dalam (Indrawati,2017). Menurut Sarason dalam (Azizah,2011) menyatakan bahwa dukungan sosial adalah keberadaan, kesediaan, kepedulian dan orang-orang yang dapat diandalkan, menghargai dan menyayangi kita. Sedangkan individu menurut Robert dan Gilbert dalam (Kusrini,2014), dukungan sosial didefinisikan sebagai sebuah keadaan dimana individu lain yang dapat dipercaya memberikan manfaat bagi seorang lain. Oktaviana dalam (Mulia,et.al.,2014),menyatakan bahwa dukungan sosial bersumber dari orang-orang yang memiliki hubungan yang berarti bagi individu seperti keluarga, teman dekat, pasangan hidup, rekan kerja, tetangga dan saudara. Teman dekat merupakan sumber dukungan sosial yang utama bagi remaja karena dapat memberikan rasa senang dan dukungan selama mengalami suatu permasalahan.

B. Sumber-Sumber Dukungan Sosial

Sumber-sumber dukungan sosial banyak diperoleh individu dari lingkungan sekitarnya dan perlu diketahui banyak sumber dukungan sosial ini efektif bagi individu yang memerlukan. Dengan pengetahuan dan pemahaman tersebut, seseorang akan tahu pada siapa ia akan mendapatkan dukungan sosial yang sesuai dengan situasi dan keinginan yang spesifik, sehingga dukungan sosial memiliki makna yang berarti bagi kedua belah pihak(Asrori,2014).

Setiap fungsi sosial memiliki sumber-sumber dukungan yang beda. Misalnya, sumber dukungan bagi individu untuk mendapatkan saran atau pendapat adalah orangtua teman atau rekan kerja. Sedangkan sumber dukungan untuk memperoleh kedekatan adalah dari pasangan hidup, sahabat, dan anggota keluarga. Orang yang memberikan dukungan sosial disebut sumber dukungan sosial. Ketika seseorang menerima dukungan sosial akan tergantung pada komposisi dan struktur jaringan sosialnya dan itu berarti seberapa besar hubungan yang mereka miliki antara orang-orang dikeluarga dan lingkungan sekitarnya(Wilis,2024). Hubungan ini dapat bervariasi pada masing-masing individu, tergantung pada siapa yang memiliki hubungan dekat, seperti : frekuensi dari hubungan, seberapa sering individu bertemu dengan orang tersebut,komposisinya, apakah orang tersebut termasuk dalam keluarga, teman, dan sebagainya,kedekatan (keintiman) adalah hubungan seseorang dengan adanya keinginan untuk bersama dan untuk percaya antara satu dengan yang lainnya (Erhamwilda,2015).

C. Dukungan Teman Sebaya

Kelompok pendukung adalah kelompok orang yang berkumpul untuk berbagi masalah dan pengalaman umum yang terkait dengan masalah, kondisi, penyakit, atau keadaan pribadi tertentu. Dalam kelompok pendukung, orang dapat berbicara dengan orang lain yang seperti mereka orang yang benar-benar memahami apa yang mereka alami dan dapat berbagi jenis wawasan praktis yang hanya dapat diperoleh dari pengalaman langsung (Hampton,2024).

Beberapa karakteristik umum kelompok pendukung meliputi:

1. Mereka terdiri dari rekan sebaya, orang-orang yang secara langsung terpengaruh oleh masalah, penyakit, atau keadaan tertentu
2. Mereka biasanya memiliki pemimpin diskusi atau fasilitator profesional atau sukarelawan
3. Mereka cenderung berukuran cukup kecil, untuk memberi kesempatan kepada semua orang untuk berbicara
4. Kehadiran bersifat sukarela (meskipun terkadang orang diharuskan menghadiri kelompok pendukung oleh pemberi kerja atau sistem pengadilan, terutama jika perilaku kriminal atau destruktif telah terlibat).

Kelompok teman sebaya merupakan gabungan dari dua orang atau lebih yang memilih untuk bersama dengan beberapa kesamaan yang mereka punya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kelompok (kumpulan, golongan, kumpulan manusia, kumpulan orang), sebaya (sama umurnya (tuanya), hampir sama (kekayaan, kepandaian, dan sebagainya) seimbang, sejajar(KBBI,2016). Menurut Chaplin dalam (Sari,2017),teman sebaya dapat diartikan sebagai teman yang berusia relatif sama atau kedewasaan yang sama.

Menurut Sarafino dalam (Sasmita & Rustika,2015), teman sebaya merupakan sumber dukungan emosional penting sepanjang transisi masa seorang remaja, karena menurut Bandura dalam (Gunarsa & Yulia,2017),masa remaja mengalami suatu pertentangan dan pemberontakan karena terlalu menitikberatkan pada ungkapan-ungkapan bebas dan ringan dari ketidakpatuhan. Dukungan sosial teman sebaya adalah dukungan yang diberikan kepada individu oleh kelompok sebayanya berupa kenyamanan secara fisik dan psikologis sehingga individu merasa dicintai, diperhatikan, dihargai sebagai bagian dari kelompok sosial.

Dukungan sosial teman sebaya adalah dukungan sosial yang bersumber dari teman sebaya dapat memberikan informasi terkait dengan hal apa yang harus dilakukan remaja dalam upaya bersosialisasi dengan lingkungannya, selain itu dapat pula memberikan timbak balik atas apa yang remaja lakukan dalam kelompok dan lingkungan sosialnya serta memberikan kesempatan remaja untuk menguji berbagai macam peran dalam menyelesaikan krisis dalam membentuk identitas diri yang optimal (Saputro & Sugiarti,2021).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan dukungan sosial teman sebaya adalah dukungan yang berasal dari teman dekat yang berupa empati, kasih sayang, perhatian, dan dapat memberikan informasi terkait hal apa yang harus dilakukan remaja sebagai upaya beradaptasi dengan baik dalam lingkungannya.

D. Manfaat Dukungan Teman Sebaya

Menurut (Hampton,2024),ada banyak manfaat dari kelompok dukungan sebaya,yakni :

1. Ketika seseorang tidak mengenal banyak - atau tidak mengenal sama sekali - orang lain yang sedang mengalami apa yang sedang dihadapinya, ia dapat merasa terisolasi dan terstigma. Kelompok dukungan membantu orang yang memiliki masalah atau penyakit agar merasa tidak sendirian dan lebih dipahami.
2. Kelompok dukungan tidak memerlukan biaya besar untuk dijalankan. Seseorang mungkin hanya perlu membayar iklan untuk kelompok tersebut dan mungkin beberapa minuman ringan. Biaya lainnya mungkin adalah tempat pertemuan, tetapi Anda biasanya dapat meminta seseorang untuk menyumbangkannya.
3. Kelompok dukungan memberdayakan orang untuk bekerja memecahkan masalah mereka sendiri.
4. Anggota dapat berbagi informasi, saling memberi informasi terkini tentang berita yang menarik bagi mereka.
5. Diantara orang-orang yang mengalami masalah serupa, ada identifikasi emosional unik yang berbeda dari jenis dukungan yang dapat diperoleh dari para profesional.
6. Anggota bertindak sebagai panutan bagi satu sama lain. Melihat orang lain yang berjuang menghadapi kesulitan yang sama dan membuat kemajuan dalam hidup mereka adalah hal yang menginspirasi dan memberi semangat.
7. Kelompok pendukung adalah tempat yang aman bagi seseorang yang perlu berbicara tentang masalah, pengalaman, perjuangan, dan pikiran yang sangat pribadi.
8. Berbicara dengan konselor atau dokter bisa sangat menakutkan bagi sebagian orang, karena hubungan tersebut cenderung memberi lebih banyak kekuasaan kepada profesional. Dalam kelompok pendukung, para anggotanya setara, hal ini dapat membuat orang merasa

jauh lebih nyaman untuk membuka diri tentang masalah mereka.

9. Berbicara dengan orang lain dalam kelompok pendukung mengurangi kecemasan, meningkatkan harga diri, dan membantu rasa kesejahteraan anggota secara keseluruhan.

E. Sasaran Kelompok Dukungan Teman Sebaya

Pertanyaan tentang siapa saja yang dapat dilayani oleh kelompok dukungan teman sebaya? Jawabannya adalah hampir semua orang lebih dari 6,25 juta orang Amerika menggunakan kelompok sebaya, dan sekitar 15 juta orang pernah berpartisipasi dalam kelompok semacam itu di suatu waktu dalam hidup mereka(Hampton,2024), kelompok dukungan digunakan untuk mengatasi berbagai masalah, seperti:

1. Penyakit, cedera, atau kondisi medis kronis
2. Gangguan makan
3. Pertanyaan tentang identitas seksual
4. Disabilitas fisik
5. Kebiasaan buruk atau tidak sehat
6. Masalah emosional
7. Kecanduan
8. Dukacita
9. Pengasuhan anak

Selain melayani orang yang secara langsung terpengaruh oleh suatu masalah, kelompok dukungan sering kali menerima anggota keluarga atau teman dari mereka yang mengalami penyakit atau kesulitan. Selain itu, banyak kelompok dukungan independen yang ada hanya untuk

anggota keluarga atau teman, misalnya sebuah kelompok untuk keluarga dan teman-teman pecandu alkohol.

F. Pembentukan Kelompok Dukungan Teman Sebaya

Membentuk kelompok dukungan sebaya perlu disusun langkah-langkah sebagai berikut(Hampton,2024) :

1. Pikirkan apa yang akan dicapai
2. Tentukan tujuan kelompok dan siapa yang ingin dijadikan dijangkau atau sasarannya. Pada langkah awal ini perlu dituliskan pernyataan visi dan misi.
3. Tentukan skala kelompok dukungan sebaya Mencari tahu apakah ada kelompok nasional, regional, atau lokal yang sudah ada dan di mana kelompok tersebut kita dapat terlibat.
4. Ada beberapa manfaat untuk mendirikan kelompok dukungan di bawah naungan organisasi yang lebih besar karena organisasi yang lebih besar sering kali dapat menawarkan sumber daya dan bantuan dalam mendirikan kelompok dukungan baru. Pengenalan nama yang datang dengan berafiliasi dengan organisasi besar dan terkenal dapat memberi kelompok kita lebih banyak kredibilitas, dan bekerja dengan organisasi yang lebih besar membuat kita tidak perlu "menemukan kembali roda" dalam memutuskan bagaimana kelompok akan beroperasi dan kita memanfaatkan model yang telah teruji dan benar.
5. Pertimbangkan apakah kelompok akan berjalan untuk jangka waktu tertentu atau untuk jangka waktu yang tak terbatas.

Kelompok pendukung dapat berlangsung lama, atau dapat dibatasi untuk jangka waktu tertentu. Misalnya, pusat krisis mungkin menawarkan kelompok pendukung selama enam minggu dua kali setahun bagi orang-orang

yang kehilangan anggota keluarga karena bunuh diri, daripada kelompok tunggal yang diadakan sepanjang tahun. Format terbatas waktu seperti ini paling cocok untuk situasi krisis, seperti duka cita atau perceraian. Kelemahan dari format ini adalah kelompok tersebut mungkin tidak tersedia pada saat seseorang membutuhkannya. Masalah yang sifatnya lebih jangka panjang misalnya penyakit kronis lebih baik ditangani oleh kelompok pendukung yang berkelanjutan dan jangka panjang.

6. Putuskan apakah kelompok akan terbuka atau tertutup. Kelompok pendukung terbuka adalah kelompok yang anggotanya dapat bergabung kapan saja selama kelompok tersebut masih ada. Ini juga berarti bahwa siapa pun dapat bergabung dengan kelompok tersebut teman, anggota keluarga, dll.

Dalam kelompok tertutup, orang-orang hanya diperbolehkan bergabung dengan kelompok tersebut pada waktu-waktu tertentu (misalnya, hanya untuk tiga minggu pertama) atau dalam keadaan tertentu (misalnya, kelompok yang hanya untuk wanita). Beberapa organisasi menawarkan kedua jenis pertemuan - pertemuan terbuka, yang dapat dihadiri siapa saja, dan pertemuan tertutup, yang hanya untuk orang-orang yang mengikuti program tersebut.

Jika kita berencana untuk menangani masalah yang sangat spesifik dan ingin seluruh kelompok menjalani proses tersebut pada saat yang sama, kita mungkin ingin mempertimbangkan untuk mengadakan kelompok tertutup. Namun, kelompok terbuka adalah yang terbaik untuk sebagian besar jenis kelompok pendukung.

7. Tentukan waktu dan tempat untuk pertemuan kelompok

Tentukan waktu yang memungkinkan sebagian besar orang hadir. Pertengahan sore pada hari kerja tidak akan baik bagi kebanyakan orang yang bekerja pada siang hari. Memilih lokasi yang baik jauh lebih penting jika dilakukan melalui kesepakatan. Bergantung pada jenis kelompok, anggota mungkin ingin bersikap hati-hati tentang kehadiran mereka, dan karena itu mungkin cenderung tidak datang jika kelompok tersebut bertemu di tempat yang sering dilalui orang di mana mereka mungkin terlihat. Misalnya, kelompok pendukung untuk mantan pelaku pelecehan anak mungkin ingin sebisa mungkin tidak terlihat.

8. Lokasinya harus mudah diakses oleh orang-orang yang akan datang ke kelompok pendukung tersebut. apakah gedungnya berada di tempat yang mudah ditemukan? apakah tempat tersebut dapat diakses oleh orang yang menggunakan kursi roda, tongkat, apakah tersedia tempat parkir yang memadai di dekatnya dan lain-lain.

Lokasi tersebut juga harus berada di suatu tempat yang membuat orang merasa cukup nyaman untuk membicarakan masalah mereka dan dapat saling memberikan dukungan. Jika kita bekerja dengan para penyintas kejahatan kekerasan, pertemuan di bagian kota yang memiliki tingkat kejahatan tinggi atau di sebelah penjara daerah dapat membuat orang-orang dalam kelompok merasa tidak nyaman atau enggan untuk datang.

9. Pilih pemimpin atau fasilitator kelompok
Memilih orang yang tepat untuk memimpin kelompok pendukung adalah hal yang sangat penting. Pemimpin kelompok atau fasilitator membuka dan menutup rapat, menentukan alur diskusi, membantu anggota belajar cara

mendengarkan dan saling memberi dukungan, serta menangani masalah yang muncul selama rapat. Fasilitator yang ideal akan memiliki kualitas sebagai berikut:

- a. Jadwal yang fleksibel: harus memiliki cukup waktu untuk melakukan tugas yang diminta dan berkomitmen untuk hadir di setiap rapat.
- b. Banyak energi: harus memiliki sikap positif, kesehatan yang baik secara umum, dan dapat bekerja setelah jam kerja jika diperlukan.
- c. Kemampuan: Idealnya, ia harus memiliki pengalaman dalam memfasilitasi kelompok tersebut. Ia juga harus bertanggung jawab, pandai berbicara, adil, terorganisasi, dan mampu bekerja sama dengan baik dengan orang lain.
- d. Dukungan: Fasilitator perlu memiliki akses ke sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan kelompok (telepon, mobil, dll.), dan orang yang dapat diandalkan untuk meminta bantuan, jika diperlukan.
- e. Keinginan untuk melakukan pekerjaan: Ia harus memiliki minat terhadap topik atau setidaknya komitmen untuk membantu orang lain. Akan lebih baik jika fasilitator memiliki Jika ini adalah kelompok baru atau ada anggota baru yang hadir untuk pertama kalinya, jelaskan aturan dasarnya. Aturan dasar yang paling umum untuk kelompok pendukung adalah bahwa semua yang dibahas dalam kelompok harus dirahasiakan. Mengingatkan kelompok tentang hal ini dari waktu ke waktu sangatlah penting. Jelaskan apakah kelompok tersebut terbuka atau tertutup dan

apa artinya. Pastikan semua orang memahami aturannya.

- f. Mintalah semua orang memperkenalkan diri, sebutkan nama mereka dan sedikit tentang mengapa mereka tertarik pada kelompok tersebut. Kemudian mulailah diskusi, baik dengan menyentuh sesuatu yang disebutkan oleh salah satu anggota atau dengan mengemukakan topik yang telah disiapkan.
10. Dorong anggota untuk mendengarkan satu sama lain
Menjadi pendengar yang baik atau pendengar yang aktif, seseorang yang jelas-jelas mendengarkan dan memahami apa yang dikatakan. Bahasa tubuh (sedikit mencondongkan tubuh ke arah pembicara, tidak gelisah), Kontak mata (menatap mata pembicara, tidak melihat ke sekeliling ruangan), pernyataan singkat yang menyemangati, mengganggu dan mengulang atau mengubah frasa terakhir pembicara untuk memberi tahu dia bahwa kita mengerti.
11. Dorong anggota untuk menawarkan dukungan satu sama lain.
Sementara kita sendiri mendukung, kita juga harus membantu orang lain dalam kelompok belajar untuk menjadi demikian juga. Tunjukkan keterampilan mendengarkan aktif yang tercantum di atas saat anggota berbicara. Tunggu sekitar 10 detik, lalu jika tidak ada anggota lain yang melakukannya, tawarkan dukungan. Anggota kelompok biasanya akan menyadari hal ini dan mulai menawarkan dukungan sendiri. Jika tidak, kita mungkin harus mengajukan pertanyaan kepada mereka tentang bagaimana mereka terpengaruh oleh pengalaman orang yang mengungkapkan hal tersebut.

12. Dorong anggota untuk berbicara tentang diri mereka sendiri.

Salah satu keuntungan dari kelompok pendukung adalah mereka dapat menciptakan suasana di mana para anggota merasa nyaman berbicara tentang dan mengatasi masalah serta pengalaman yang sangat pribadi. Tindakan mengungkapkan informasi pribadi memberi anggota lain kesempatan untuk menawarkan dukungan, ide, dan bantuan. Hal ini juga mendorong anggota lain untuk berbagi pengalaman mereka sendiri dan menumbuhkan suasana saling percaya dalam kelompok. Untuk menjaga kepercayaan tersebut, fasilitator mungkin perlu mengungkapkan informasi dari waktu ke waktu.

Saat seorang anggota mengungkapkan informasi, fasilitator mungkin harus memandu diskusi agar anggota merasa nyaman atau mendorong orang lain untuk bergabung dalam diskusi. Mengajukan pertanyaan terbuka, yang tidak dapat dijawab dengan "ya" atau "tidak" sangat berguna pada tahap ini.

Kita juga dapat merencanakan topik terlebih dahulu. Beberapa kelompok pendukung melakukan hal-hal seperti meminta anggotanya membaca atau membuat jurnal tentang pengalaman mereka untuk membantu memicu diskusi.

13. Tawarkan dukungan

Inilah alasan utama kelompok dukungan ada! untungnya, menawarkan dukungan adalah salah satu hal paling sederhana yang dapat dilakukan dalam menjalankan kelompok pendukung. Memberikan dukungan kepada anggota dapat membantu mereka menyadari bahwa mencapai tujuan mereka adalah sangat mungkin,

memberi mereka harapan, atau sekadar memberi tahu mereka bahwa kita berempati dengan apa yang mereka alami.

Dukungan terdiri dari membuat pernyataan yang menunjukkan pengertian, simpati, dan perhatian kita. Dengarkan perasaan yang diungkapkan oleh anggota, dan tanggapilah perasaan tersebut. Dukungan juga dapat diungkapkan melalui bahasa tubuh (seperti melakukan kontak mata atau tersenyum) atau sentuhan (berpelukan, menepuk lengan anggota). Kehati-hatian harus dilakukan dalam menggunakan sentuhan sebagai bentuk dukungan dalam beberapa keadaan, seperti kelompok pendukung untuk korban pelecehan seksual anak, sentuhan mungkin mengancam dan tidak nyaman alih-alih menenangkan.

14. Bantu anggota menyelesaikan masalah

Meskipun memecahkan masalah seharusnya bukan satu-satunya tujuan kelompok pendukung, banyak anggota berharap dan mengharapkan hal itu. Semua anggota harus mengambil bagian dalam proses pemecahan masalah sehingga tidak ada satu orang pun yang dianggap sebagai solusi atas kesulitan mereka. Tugas fasilitator adalah membantu anggota belajar cara saling membantu dalam memecahkan masalah.

Berikut langkah-langkah untuk memecahkan masalah:

- a. Mengklarifikasi masalah: pastikan semua orang memahami masalah sepenuhnya. Jika kita tidak yakin apa masalahnya, ajukan pertanyaan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.
- b. Membicarakan alternatif: kemukakan kemungkinan solusi untuk masalah tersebut, tetapi berhati-hatilah untuk menyampaikannya dengan cara yang tidak memberikan nasihat. Misalnya, daripada "Kamu harus

melakukan ini," kata-kata yang lebih baik adalah "Aku ingin tahu bagaimana jadinya jika kamu mencoba ini" atau "Mungkin kamu bisa melakukan ini." Memberi tahu orang lain apa yang harus dilakukan bukanlah tujuan atau tanggung jawab kelompok pendukung. Hal ini menghilangkan perasaan seseorang bahwa ia dapat menangani masalahnya sendiri dan dapat membuat orang lain merasa diserang dan tidak nyaman. Cobalah meminta anggota untuk memberi tahu apa yang berhasil bagi mereka dalam situasi yang sama. Kita juga dapat bertanya kepada orang yang memiliki masalah tersebut apa yang menurutnya dapat berhasil.

- c. Memilih opsi yang akan diambil: mintalah kelompok tersebut mendiskusikan pro dan kontra dari setiap saran, kita kemudian dapat membiarkan orang yang memiliki masalah tersebut mengambil keputusan, atau ia mungkin ingin meluangkan waktu sendiri untuk mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinannya. Beri tahu ia bahwa kelompok tersebut peduli dan ingin tahu bagaimana hasilnya.
 - d. Menawarkan bantuan: terkadang anggota mungkin menawarkan bantuan satu sama lain. Misalnya, jika masalah yang sedang dibahas adalah masalah transportasi anggota untuk menghadiri pertemuan, anggota lain mungkin menawarkan untuk mengantar orang tersebut.
15. Tutup pertemuan

Kebanyakan pertemuan kelompok pendukung berlangsung antara satu hingga dua jam. Jika kelompok tersebut terjebak dalam diskusi yang sangat intens atau membantu anggota memecahkan masalah, kita dapat menambahkan beberapa menit, tetapi umumnya lebih

baik untuk berhenti sebelum semua orang lelah dan ingin pergi. Ketika diskusi hampir berakhir atau ketika waktu berakhir yang telah disepakati sebelumnya telah tiba, selesaikan semuanya. Berikut ini beberapa cara untuk menutup pertemuan:

- a. Buat pernyataan ringkasan: rangkum topik yang dibahas dan alternatif yang dipilih. Soroti setiap pengamatan positif atau solusi yang muncul.
- b. Meminta komentar atau pertanyaan tambahan: periksa apakah ada orang dalam kelompok yang ingin menambahkan sesuatu.
- c. Ingatkan anggota tentang pertemuan berikutnya: beri tahu semua orang tentang waktu dan tempat untuk pertemuan berikutnya.
- d. Minta sukarelawan, jika perlu: Jika kita memerlukan bantuan untuk sumbangan, minuman, transportasi, atau kebutuhan kelompok lainnya, ini adalah waktu terbaik untuk memintanya. Meminta bantuan dari anggota mendorong mereka untuk mengambil tanggung jawab kepemimpinan dan menumbuhkan rasa investasi pribadi dalam keberhasilan kelompok.
- e. Berikan salam penutup: ucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah hadir, ucapkan selamat tinggal, dan dorong mereka untuk datang lagi.
- f. Buat catatan penutup: segera setelah rapat, buat beberapa catatan singkat tentang apa yang dibahas selagi masih segar dalam ingatan kita. Informasi ini dapat digunakan untuk memulai rapat berikutnya. Simpan semua catatan tentang kelompok di tempat yang aman untuk memastikan kerahasiaan.

G. Peran dan Fungsi Teman Sebaya

Peranan teman sebaya bagi remaja merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan pada masa-masa remaja. Teman sebaya memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan sosial emosional remaja. Interaksi yang positif dengan teman sebaya tidak hanya membantu mereka mengelola emosi, tetapi juga meningkatkan kecerdasan emosional, keterampilan sosial, dan semangat untuk belajar. Berikut ini peranan teman sebaya dalam perkembangan sosial emosional remaja (Fadhilah & Mukhlis, 2021) :

1. Sumber dorongan emosional

Teman sebaya menjadi sumber dorongan emosional yang sangat penting bagi remaja. Berinteraksi dengan teman sebaya memberikan kesempatan bagi remaja untuk belajar mengelola emosi, mengembangkan empati, serta membangun keterampilan sosial yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kelompok teman sebaya yang positif, remaja dapat saling mendukung dan menguatkan dalam menghadapi berbagai tantangan emosional, seperti kecemasan atau stres.

2. Meningkatkan Kecerdasan Emosional

Ketika remaja bergaul dengan teman sebaya secara positif, hal ini dapat meningkatkan kecerdasan emosional mereka. Teman sebaya menyediakan ruang untuk berbagi perasaan dan pengalaman yang memungkinkan remaja untuk belajar mengatasi masalah dengan cara yang sehat. Misalnya, melalui obrolan santai atau diskusi kelompok, remaja belajar untuk lebih memahami dan merespons perasaan orang lain, yang pada gilirannya membantu

mereka menjadi lebih peka terhadap emosi diri sendiri dan orang lain.

3. Pembangunan Interaksi Sosial yang Sehat

Interaksi yang sehat dengan teman sebaya mengajarkan remaja keterampilan sosial yang penting, seperti cara mengekspresikan diri dengan tepat, mengelola konflik secara konstruktif, dan berkomunikasi secara efektif. Kecerdasan emosional tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga oleh lingkungan sosial tempat remaja berkembang. Teman sebaya menciptakan konteks sosial di mana remaja dapat mengasah keterampilan ini dalam kehidupan sehari-hari.

4. Mendukung Semangat dan Motivasi Belajar

Teman sebaya yang saling mendukung dapat memperkuat semangat belajar dan rasa percaya diri remaja. Kebiasaan positif yang terbentuk dalam kelompok teman sebaya, seperti belajar bersama atau saling memotivasi dalam mengerjakan tugas, dapat meningkatkan motivasi akademik. Misalnya, remaja yang memiliki teman sebaya yang rajin dan memiliki tujuan akademik yang jelas cenderung terinspirasi untuk mengikuti jejak tersebut, yang berdampak pada peningkatan hasil belajar mereka.

Hubungan dengan teman sebaya tidak selalu dapat menghadirkan dukungan yang bersifat positif, tetapi ada juga yang bersifat negatif. Berikut beberapa peran teman sebaya yang bersifat positif :

1. Teman sebaya berperan untuk memberikan dukungan sosial, moral, dan emosional. Dukungan-dukungan tersebut diwujudkan melalui sikap saling perhatian antaranak, saling memberikan nasihat dan masukan ketika

- seseorang mendapat masalah, saling bercerita, berkeluh kesah, dan saling mengadu ketika ada masalah.
2. Teman sebaya berperan untuk mengajarkan berbagai keterampilan sosial. Salah satu keterampilan sosial yang dapat muncul dalam pergaulan teman sebaya adalah kerja sama seperti dalam hal belajar, mengerjakan tugas, dan menjalankan hobi.
 3. Teman sebaya mengajarkan kemampuan untuk mengontrol diri, tidak mudah marah, dan tidak mementingkan diri sendiri.
 4. Teman sebaya juga mengajarkan keterampilan memecahkan berbagai permasalahan di kehidupan sehari-hari.
 5. Teman sebaya berperan sebagai agen sosialisasi bagi orang lain. Teman sebaya sebagai agen sosialisasi tercermin dari kebiasaan seseorang untuk saling mengingatkan mengenai aturan-aturan sekolah.

Sedangkan menurut Santrock dalam (Sari,2017),fungsi terpenting dari hadirnya teman sebaya adalah sebagai sumber informasi, seperti saling memberi dan menerima umpan balik (*feedback*) mengenai kemampuan yang dimiliki dan sebagai perbandingan baik buruknya suatu hal. Sosok teman sebaya memberikan kasih sayang, pengertian, kepedulian, dan tuntutan secara moral yang bermanfaat sebagai eksperimen dan sarana memperoleh kemandirian dan otonomi Feldman dalam (Oktarini,2019),Stroul dalam (Rufaida,2018), mengartikan dukungan sosial teman sebaya sebagai suatu runtutan peristiwa atau yang meliputi sokongan, hubungan selaku sahabat, empati, saling memberi, dan bantu membantu yang berpotensi mengurangi intensitas gangguan kejiwaan, seperti perasaan

kesepian, penolakan, perlakuan diskriminasi, hingga frustrasi. Kelompok dukungan sebaya juga memiliki peran dalam kepatuhan ODHA dalam mengkonsumsi ARV (Anok,2018). Begitu pula dukungan teman sebaya juga berperan dalam Praktik Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI) pada remaja (Fatmasari & Aniroh,2021).

Meskipun teman sebaya dapat memberikan pengaruh positif dalam perkembangan sosial emosional remaja, mereka juga bisa menjadi faktor risiko jika berada dalam pergaulan yang negatif. Sebagai contoh, jika remaja bergaul dengan teman sebaya yang terlibat dalam perilaku merokok, narkoba, atau kekerasan, mereka lebih berisiko untuk terpengaruh oleh kebiasaan buruk ini. Oleh karena itu, sangat penting bagi remaja untuk memilih teman yang dapat memberikan dampak positif dalam perkembangan mereka.

H. Dimensi dan Aspek Dukungan Teman Sebaya

Dukungan teman sebaya adalah bantuan atau dukungan yang berasal dari teman seusianya yang memiliki hubungan sosial yang akrab dengan teman yang memberinya bantuan. Bentuk dukungan ini dapat berupa informasi, tingkah laku, materi, atau bahkan sampai individu yang menerima bantuan merasa disayangi, diperhatikan dan bernilai.

Dimensi Dukungan Sosial Menurut Sarafino dalam (Hanapi,2018) ada empat aspek dukungan sosial.

1. Dukungan emosi.

Merupakan ekspresi empati, kepedulian, dan perhatian kepada seseorang tersebut dalam kondisi stress.

2. Dukungan penghargaan.

Dukungan ini terjadi melalui ekspresi orang mengenai hal yang positif tentang orang tersebut membesarkan hati, setuju dengan ide-ide atau perasaan individu, perbandingan positif antara individu tersebut dengan individu lain, seperti pada orang lain yang memiliki kekurangan atau lebih buruk.

3. Dukungan instrumen.

Dukungan ini meliputi bantuan langsung seperti jika seseorang diberi atau dipinjam uang atau dibantu dengan cara melaksanakan tugas atau pekerjaan pada saat individu tersebut berada dalam kondisi stress.

4. Dukungan informasi.

Dukungan ini meliputi pemberian nasehat, saran umpan balik mengenai bagaimana orang tersebut berada dalam kondisi stress.

House dalam (Mahmudi,2014), membedakan empat bentuk atau dimensi dukungan sosial teman sebaya,yaitu:

1. Dukungan emosional

Mencakup dukungan empati, kepedulian dan perhatian terhadap orang yang bersangkutan.

2. Dukungan penghargaan

Terjadi lewat ungkapan hormat (penghargaan) positif untuk orang itu, dorongan maju atau persetujuan dengan gagasan atau perasaan individu.

3. Dukungan instrumental

Mencakup bantuan langsung, seperti kalau orang-orang memberi pinjaman uang kepada orang itu atau menolong dengan pekerjaan pada waktu mengalami stress.

4. Dukungan informative

Mencakup memberi nasehat, petunjuk-petunjuk, saran-saran atau umpan balik.

Adapun aspek dukungan sosial menurut Taylor dalam (Sekarina,2020) menyatakan adanya empat aspek,yaitu sebagai berikut:

1. *Tangible Assistance*

Dukungan penyediaan bahan, seperti pemberian dukungan keuangan atau barang

2. *Informational Support*

Informasi dan pemecahan masalah yang diberikan kepada individu untuk memahami situasi stres yang terjadi.

3. *Emotional Support*

Keyakinan yang diberikan kepada seorang individu bahwa dirinya berharga dan bernilai.

4. *Invisible Support*

Bantuan yang diberikan oleh individu lain tanpa disadari oleh individu penerima.

Sedangkan aspek-aspek dalam dukungan sebaya menurut Serafino dalam (Sasmita & Rustika,2015) adalah sebagai berikut :

1. Dukungan emosi (*emotional*)

Aspek dukungan emosi meliputi tindakan mengungkapkan atau mengekspresikan rasa empati, peduli, dan perhatian dengan memberikan kenyamanan, ketenangan, dan perasaan dicintai pada individu penerima.

2. Dukungan penghargaan (*esteem support*)

Aspek dukungan penghargaan melibatkan pengungkapan hal positif, penghargaan, motivasi, dan

pengakuan atas gagasan atau perasaan terhadap individu yang bersangkutan.

3. Dukungan instrumental (*tangible or instrumental support*)

Aspek dukungan instrumental mencakup bantuan secara langsung dalam berbagai bentuk, seperti waktu, jasa, atau materi. Pemberian dalam bentuk materi seperti pinjaman uang atau pemberian jasa dapat berbentuk pemberian pertolongan pada pekerjaan atau tugas individu

4. Dukungan informatif (*informational support*)

Aspek dukungan informatif meliputi pemberian nasehat, informasi, petunjuk, sugesti, atau umpan balik atau feedback yang dibutuhkan oleh individu penerima.

5. Dukungan jaringan sosial (*companionship support*)

Aspek dukungan jaringan sosial mencakup pengondisian dimana individu akan diakui sebagai anggota suatu grup atau kelompok dengan ketertarikan dan/atau kegiatan sosial yang sama. Aspek dukungan jaringan sosial juga dapat disebut sebagai dukungan persahabatan (*companionship support*) yang mengartikan adanya jalinan sosial secara positif dan mendorong individu untuk membangun interaksi dan berkegiatan menghabiskan waktu bersama.

BAB 6

PERAN DUKUNGAN TEMAN SEBAYA (*PEER SUPPORT*) PADA *MENSTRUAL HYGIENE MANAGEMENT* REMAJA

Peran dukungan teman sebaya memiliki keterkaitan dengan tingkat pengetahuan remaja tentang *menstrual hygiene management* (Aniroh,et.al,2019) dan (Armini,et.al,2023). Teman sebaya memiliki peran penting terutama terhadap perilaku remaja(Anggraeni, et.al.2023), informasi dari teman sebaya memberikan dampak yang lebih baik karena remaja akan lebih terbuka dan mudah berkomunikasi dengan teman seusianya,dibandingkan dengan orang tua ataupun guru di sekolah(Nisa,2020),hal tersebut terjadi karena koneksi yang dibangun antar diri mereka lebih mudah dipahami dan diterima daripada koneksi yang dilakukan oleh orang tua atau orang yang berusia lebih dewasa dari remaja tersebut (Lavenia,2019).

Terciptanya dukungan dari teman sebaya karena usia remaja mempunyai sifat menaruh perhatian besar pada orang lain seperti orangtua, kelompok termasuk teman sebayanya yang menjadikan adanya hubungan saling mengerti dan memahami masalah masing-masing, saling memberi nasihat dan simpati,selain itu,dukungan informasi yang diberikan oleh teman sebaya akan menumbuhkan rasa percaya diri remaja karena perubahan yang terjadi dan membantu mencegah gangguan kesehatan ketika menstruasi (Sommer,et.al,2016), namun ada kalanya remaja puteri kurang mendapatkan informasi dari teman sebaya mengenai kebersihan diri secara lengkap, umumnya remaja putri hanya mendapatkan informasi

untuk menggunakan pembalut saat menstruasi dan menjaga agar tidak mengotori pakaian, namun tidak mendapatkan penjelasan mengenai cara memilih pembalut yang baik, cara membersihkan diri dan pembalut yang digunakan serta cara menjaga lingkungan tetap bersih selama menstruasi, padahal kenyataannya kebersihan diri adalah hal yang harus diperhatikan dalam perkembangan remaja menjadi dewasa, karena ketrampilan menjaga kebersihan diri selama menstruasi tersebut akan terus dipraktikkan sepanjang hidup selama seseorang mendapatkan menstruasi (Aniroh,et.al,2019).

Praktik *menstrual hygiene management* dikaitkan dengan tingkat pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi (Mishra,et.al.,2016). Pemahaman, sikap, serta tindakan personal hygiene ketika menstruasi pada murid perempuan akan efektif salah satunya dengan pendidikan kesehatan teknik *peer group* (Wilis & Wintarsih,2024). selain karena dukungan teman sebaya dan tingkat pengetahuan remaja tersebut, juga tidak dapat dipungkiri bahwa peran orang tua,keterpaparan informasi dari media dan ketersediaan infrastruktur juga turut punya andil dalam pelaksanaan *menstrual hygiene management* yang baik pada remaja (Dolang,et.al.,2017).

Berdasarkan penelitian (Lucktong,et.al.,2017), menyatakan bahwa pengasuhan yang aman dan kelekatan teman sebaya berkaitan dengan *psychological well-being* pada remaja. Remaja dapat memperoleh dukungan sosial dari teman sebayanya apabila ia memiliki teman dekat. Teman dekat cenderung akan memberikan dukungan sosial kepada temannya. Remaja yang tidak memiliki teman dekat cenderung tidak memperoleh dukungan sosial dari teman sebaya. Sesuai dengan pendapat Krammer dalam (Himmah,20157),bahwa individu yang tidak memiliki teman dekat cenderung mempunyai *psychological well-being* yang rendah. Namun,

dukungan sosial teman sebaya bukanlah faktor utama dalam menentukan tingkat *psychological well-being* pada remaja, karena masih ada faktor-faktor lain seperti faktor demografis (usia, jenis kelamin, kelas sosial ekonomi, budaya), faktor kepribadian, dan faktor religiusitas.

BAB 7

PENUTUP

Kami sangat berharap monograf ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi remaja, tenaga kesehatan, dan masyarakat luas dalam upaya *menstrual hygiene management*. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan, sikap serta perilaku *menstrual hygiene management* yang baik, kami merekomendasikan beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan:

1. Edukasi Berkelanjutan
2. Penyelenggaraan program pendidikan kesehatan di area sekolah dan komunitas untuk meningkatkan pemahaman tentang *menstrual hygiene management*.
3. Kerja Sama dengan Layanan Kesehatan
4. Mendorong kolaborasi antara sekolah dengan penyedia layanan kesehatan untuk edukasi sebagai upaya promotif tentang *menstrual hygiene management*.
5. Penggunaan Media Sosial
6. Memanfaatkan media sosial sebagai alat bantu untuk edukasi dan pemantauan kesehatan remaja.
7. Kebijakan yang Mendukung
8. Pemerintah dan lembaga terkait perlu mendukung *menstrual hygiene management* yang baik melalui kebijakan yang mempermudah akses terhadap informasi kesehatan dan pelayanan kesehatan reproduksi remaja pada umumnya.

Pada akhirnya, kami ingin menggarisbawahi bahwa *menstrual hygiene management* pada remaja merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya menjadi tanggung

jawab individual remaja, namun juga diperlukan kepedulian keluarga, lingkungan dan pemangku kebijakan, karena sesungguhnya kesehatan remaja adalah merupakan modal dasar untuk hidup secara produktif dalam rangka pembangunan bangsa.

Kami mengucapkan terima kasih kepada para pembaca monograf ini, semoga informasi yang telah dijabarkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, R. (2015). Pengaruh Pendidikan Kesehatan Terhadap Tingkat Pengetahuan Remaja Putri Mengenai Menarche Di SMP Negeri Binamu Kabupaten Jeneponto. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 9, 122.
- Anggraeni,L.,Lubis,D.R., Nurdini,L.(2023),Pengetahuan, Sikap, Dan Dukungan Teman Sebaya Berhubungan Dengan Kebersihan Diri Saat Menstruasi Pada Remaja Putri Di Pondok Pesantren. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 14(1), 2023: 71 – 83
- Aniroh,U.,Mawardika,T.,Saparwati,M.,(2019).Hubungan Dukungan Teman Sebaya(Peer Support) dengan Pengetahuan dan Sikap Menstrual Hygiene Management pada Remaja Putri. *Proceeding Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) IPEMI Jawa Tengah ke-2,Surakarta,Tahun 2019*
- Aniroh, U., Mawardika, T., Choiriyah, Z.(2022). The Effectiveness of Education through Animated Media to Improve Teenage Girl's Knowledge and Attitudes about Prevention of Anemia. *Annals of the Romanian Society for Biology*.
<https://www.proquest.com/openview/4dc734d36dd17a3b8fde1daa960b32c/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2031963>
- Aniroh, U., Mawardika, T., Choiriyah, Z.(2022). The Effectiveness of Education through Animated Media to Improve

Teenage Girl's Knowledge and Attitudes about Prevention of Anemia. Annals of the Romanian Society for Biology.
[https://www.proquest.com/openview/4dc734d36dd17a3b8fde1daa960b32c/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2031963,](https://www.proquest.com/openview/4dc734d36dd17a3b8fde1daa960b32c/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2031963)

Aniroh, U., Mawardika, T., (2024). Studi Komparasi Pengetahuan dan Sikap tentang Manajemen Kebersihan Menstruasi Sesudah Pemberian Edukasi Menggunakan Audio Visual dengan Booklet Print. Indonesian Jurnal of Midwifery.
<https://jurnal.unw.ac.id/index.php/ijm/article/view/3212>

Anok,M.,R.,Aniroh,U.,& Wahyuni,S.,(2018). Wilis,D.,S.,& Wintarsih (2024). Efektivitas Pendidikan Kesehatan Metode Peer Group Terhadap Pengetahuan, Sikap, Dan Perilaku Personal Hygiene Saat Menstruasi Pada Siswi Kelas 10 di SMA Perguruan Rakyat 2. Manuju: Malahayati Nursing Journal, Volume 6 Nomor 3 Tahun 2024] Hal 1222-1228

Ansori,H.R., (2016). Hubungan Dukungan Sosial Dengan Efikasi Diri Dalam Menyelesaikan Tugas Perkuliahan Pada Mahasiswa Baru Teknik Arsitektur UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi Sujana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang 2016, 33-34

- Anwar,I.,C.,(2022). <https://tirto.id/apa-saja-syarat-kelompok-sosial-menurut-soerjono-soekanto-gunz>. Terbit 23 Jul 2022Diakses tanggal 20 Desember 2024
- Armini,N.K.A,et.al.,(2023). Knowledge and peer support for increase Menstrual Hygiene Management (MHM) in adolescents. *Healthcare in Low-resource Settings* 2023; volume 11(s1):11193
- Azizah, L. M. (2011). *Keperawatan Lanjut Usia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Batubara, J. R. (2016). Adolescent Development (Perkembangan Remaja). *Sari Pediatri*, 12(1), 21. <https://doi.org/10.14238/sp12.1.2010.21-9>.
- Belayneh and B. Mekuriaw, (2019). Knowledge and menstrual hygiene practice among adolescent school girls in southern Ethiopia: a cross-sectional study, *BMC Public Health*, vol. 19, no. 1, p. 1595.
- Burnet Institute. (2015). *Menstrual Hygiene Management in Indonesia.Understanding Practices, Determinants and Impacts Among Adolescents School Girls . Final Report 2 February 2015*. Burnet Institute.
- Chinyama,(2019). Menstrual hygiene management in rural schools of Zambia: a descriptive study of knowledge, experiences and challenges faced by schoolgirls, *BMC Public Health*, vol. 19, no. 1, p. 16.
- Diananda, A. (2019). Psikologi Remaja Dan Permasalahannya. *Journal Istighna*, 1(1), 116–133.<https://doi.org/10.33853/istighna.v1i1.20>

- Dolang MW, Rahma, Ikhsan M.(2017). Faktor Yang Berhubungan Dengan Praktik Hygiene Menstruasi Pada Siswi SMA Negeri1 Sesean Kabupaten Toraja Utara. Jurnal MKMI. 2017;36–44.
- Erhamwilda,(2015). Konseling Sebaya Alternatif Kreatif Layanan Bimbingan Konseling di Sekolah. Yogyakarta: Media Akademi, (2015), Cet. 1, hlm. 41.)
- Fadhilah, N., & Mukhlis, A. M. A. (2021). Hubungan lingkungan keluarga, interaksi teman sebaya dan kecerdasan emosional dengan hasil belajar siswa. Jurnal Pendidikan, 22(1), 15-31.
- Fatmasari,N.,M.&Aniroh,U.,(2021). Korelasi Dukungan Teman Sebaya dengan Praktik Pemeriksaan. Payudara Sendiri (SADARI) pada Remaja. Pro Health Jurnal Ilmiah Kesehatan. Vol 3, No 2 (2021)
- Fitria, A, and Mawardika, T. (2023). "Perbedaan Pengetahuan dan Sikap Menghadapi Menarche Sebelum dan Sesudah diberikan Pendidikan Kesehatan dengan Media Video". Jurnal. Kesehatan Husada. <https://jurnal.ukh.ac.id/index.php/JK/article/view/978>
- Gunarsa, S., & Y. S. (2017). Psikologi Perkembangan Anak & Remaja. Jakarta: LIBRI.
- Hampton,C.,(2024).<https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/implement/enhancing-support/peer-support-groups/main>. National Self-Help Clearinghouse Graduate School and University

Center City University of New York 33 West 42nd Street, Room 1227 New York, NY 10036 (212) 840-7606

- Hanapi, I., dkk.(2018). Dukungan Sosial Teman Sebaya Dengan Self Efficacy Dalam Menyelesaikan Skripsi Pada Mahasiswa. Jurnal RAP UNP, Vol.9 No.1. 39
- Himmah, F(2015). Hubungan religiusitas dengan kesejahteraan psikologis. Skripsi. Fakultas Psikologi dan Kesehatan. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
- Indrawan, T.,A.,(2020). Modul pembelajaran SMA sosiologi kelas XI: masalah dan eksklusi sosial. 21 Apr 2021 <https://repositori.kemdikbud.go.id/21936/>.Diakses tanggal 18 Desember 2024
- Indrawati, Triana. (2017). Peranan kecerdasan emosi dan dukungan sosial terhdap kesejahteraan psikologis siswa SMP Terbuka di Cirebon. Jurnal Edukasia Islamika, 2, (1),. 77-103.
- Karminingtyas., S.R., Pujiastuti., Anastasia., Mawardika., T, (2023). Edukasi Kesehatan Menstrual Hygiene Dan Penatalaksanaan Premenstrual Syndrome. Jurnal Komunita.<https://journal.pelitanusa.or.id/index.php/komunita/article/view/37>
- Kaur, K. Kaur, and R. Kaur,(2018). Menstrual hygiene, management, and waste disposal: practices and challenges faced by girls/women of developing

countries. Journal of Environmental and Public Health, vol. 2018, Article ID 1730964, 9 pages,.

KBBI VI Daring.(2016).[https://kbbi.kemdikbud.go.id/Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa](https://kbbi.kemdikbud.go.id/Badan_Pengembangan_dan_Pembinaan_Bahasa), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.diakses tanggal 19 Desember 2024.

Kharisma, N., & Latifah, L. (2015). "Pengaruh Motivasi, Prestasi Belajar, Status Sosial Ekonomi Orang Tua Dan Lingkungan Teman Sebaya Terhadap Minat Melanjutkan Pendidikan Ke Perguruan Tinggi Pada Siswa Kelas Xii Kompetensi Keahlian Akuntansi Di Smk Negeri SeKota Semarang Tahun Ajaran 2014". Economic Education Analysis Journal, 4(3), 833–846.

Kim and J. S. Choi, (2019). Female university students' menstrual-hygiene management and factors associated with genitourinary-tract infections in Korea. Women & Health, vol. 60, no. 5, pp. 559–569, .

Kusmiran, E. (2014). Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita. Jakarta: Salemba Medika

Kusumastuti,D.A. Hubungan Pengetahuan dan Karakteristik Remaja Putri tentang Menstruasi dengan Perilaku Higienis Saat Menstruasi. The 3rd University Research Colloquium (URECOL) 2016. Diakses pada tanggal 2 november 2019

- Kusrini, W. &. (2014). Hubungan dukungan sosial dan kepercayaan diri dengan prestasi bahasa inggris siswa kelas VIII SMP Negeri 6 Boyolali. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 15(2), 131-140
- Lavenia C, Dyasti JA. Studi Komparatif Personal Hygiene Mahasiswa Universitas Indonesia di Indekos dan Asrama. *J KSM Eka Prasetya UI*. 2019;1(4):1–9.
- Lucktong, A., Salisbury. T.T., & Chamrathirithong, A. (2017). The impact of parental, peer and school attachment on the psychological well- being of early adolescents in Thailand. *International Journal of Adolescence and Youth*, ISSN: 0267- 3843, 1-16.
- MacRae, E.,R.,T. Clasen, M. Dasmohapatra, and B. A. Caruso, (2019). It's like a burden on the head': redefining adequate menstrual hygiene management throughout women's varied life stages in Odisha, India," *PLoS One*, vol. 14, no. 8, Article ID e0220114.
- Mahmudi, M. H. (2014). Efikasi Diri, Dukungan Sosial dan Penyesuaian diri dalam Belajar. *Jurnal Psikologi Indoneia*, 3.
- Margiyanti,R.,(2022).https://tirto.id/apa-tahapan-pembentukan-kelompok-sosial-forming-hingga-adjourning-gvai#google_vignette. Terbit 15 Aug 2022.diakses tanggal 20 Desember 2024
- Marmi. (2023). Kesehatan Reproduksi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Marwoko, G. (2019). Psikologi Perkembangan Masa Remaja. Tasyiri: Jurnal Tarbiyah Syariah Islamiah, 26(1).
- Mawardika, T., Aniroh., Ismiriyam F, Nurhaliza, LS, Azzahra, UN, Rahmaningtyas, N.(2024). Gerakan Tanggap Sehat Reproduksi (RATASEKSI) pada Masa Remaja sebagai Upaya Pencegahan Stunting. Indonesian Journal of Community Empowerment. <https://jurnal.unw.ac.id/index.php/IJCE/article/view/3337>
- Mawardika, T.,Muttoharoh, W. (2019). Penerapan Tehnik Massage Effleruge pada Punggung terhadap Penurunan Intensitas Nyeri Haid. Jurnal Keperawatan. <http://journal.stikeskendal.ac.id/index.php/Keperawatan/article/view/537>
- Mawardika, T., Aniroh, U., Ismiriyam, FV., (2022)., Tapping Touch (TATO) sebagai Upaya Penurunan Nyeri Disminore. Indonesia Journal of Community Empowerment(IJCE).<https://jurnal.unw.ac.id/index.php/IJCE/article/view/1808>
- Mawardika, T., Aniroh, U., Ismiriyam, FV., (2023)., Swedish Masase Terapi mampu Menurunkan Nyeri Haid. Indonesia Journal of Community Empowerment(IJCE).<https://jurnal.unw.ac.id/index.php/IJCE/article/view/1808>
- Mesarini, B. A., & Astuti, V. W. (2023). Stress dan Mekanisme Koping Terhadap Gangguan Siklus Menstruasi Pada Remaja Putri. Jurnal STIKES, 6(1), 31–42.

- Michael, Q. Iqbal, S. Haider et al.(2020). Knowledge and practice of adolescent females about menstruation and menstruation hygiene visiting a public healthcare institute of Quetta, Pakistan. *BMC Women's Health*, vol. 20, p. 4,
- Mishra SK, Dasgupta D, Ray S. A study on the relationship of sociocultural characteristics, menstrual hygiene practices and gynaecological problems among adolescent girls in Eastern India. *Int J Adolesc Med Health* 2016;29:/j/ijamh.2017.29.issue-5/ijamh-2015-0111/ijamh-2015-0111.xml.
- Mulia, L. O., V. E., & R. W. (2014). Hubungan Dukungan Sosial Teman Sebaya Terhadap Tingkat Resiliensi Remaja di Panti Asuhan. *JOM PSIK*, 1.
- Ningsih, W. A., Suseno, M. R., Yuni, B., & Hamidiyanti, F. (2021). Remaja Putri Tentang Personal Hygiene Pada Masa Wilayah Kerja Puskesmas Kuripan Kabupaten Lombok Barat 2021. *Jurnal Kebidanan*. Vol.10 No.2 Oktober 2021.
- Nisa AH, Winarni S, Dharmawan Y. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Praktik Personal Hygiene Saat Menstruasi Pada Remaja Putri Pondok Pesantren Al Asror Kota Semarang Tahun 2019. *J Kesehat Masy*. 2020;8(1):145–51
- Nnennaya, E. U., Atinge, S., Dogara, S. P., & Ubandoma, R. J. (2021). Menstrual hygiene management among adolescent school girls in Taraba State , Nigeria. *Afri Health Sci*. Vol.21(2), 842–851.

- Novitasari, dyah ayu, Soeharto, & Wiyanti, S.(2014). "Kontribusi Dukungan Sosial Teman Sebaya terhadap Adekuasi Penyesuaian Diri di Sekolah pada siswa SMP". *Jurnal Program Studi Bimbingan Dan Konseling*, 2((2 December), 59–63.
- Oktariani, O. (2019). Hubungan self efficacy dan dukungan sosial teman sebaya dengan self regulated learning pada mahasiswa Universitas Potensi Utama Medan. *Jurnal Psikologi Kognisi*, 2(2), 98-112.
- Proverawati, A., & Misaroh, S. (2017). *Menarche Menstruasi Pertama Penuh Makna*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Putra, I. G. N. E., Pradnyani, P. E., Pragmaningtyas, M. S., Kusumadewi, N. M. C., & Widarini, N. P. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Umur Menarche (Menstruasi Pertama) Pada Siswi Sekolah Dasar Di Kota Denpasar. *BIMKMI*, 4(1), 31–38.
- Ramathuba, Dorah U. (2015). Menstrual knowledge and practices of female adolescents in Vhembe district, Limpopo Province, South Africa. *Curationis*, 38(1), 1–6. <https://doi.org/10.4102/curationis.v38i1.1551>
- Rufaida, H. &. (2018). Hubungan antara dukungan sosial teman sebaya dengan penyesuaian diri pada mahasiswa rantau dari Sumatera di Universitas Diponegoro. *Jurnal Empati*, 222. <https://doi.org/10.14710/empati.2017.19751>
- Sari, P. P., & Indrawati, E. S. (2017). Hubungan antara dukungan sosial teman sebaya dengan resiliensi akademik

- pada mahasiswa tingkat akhir jurusan x fakultas teknik Universitas Diponegoro. *Jurnal Empati*, 5(2), 177 - 182.
- Saputro,Y.A.,Sugiarti,R.(2021).Dukungan Sosial Teman Sebaya dan Konsep Diri terhadap Penyesuaian Diri pada Siswa SMA Kelas X. *Philanthropy Journal of Psychology* Vol 5 Nomor 1 (2021), 59-72.
- Sarafino, E., & Smith, T. (2011). *Health psychology biopsychosocial Interaction* . John Wiley & Sons
- Sari, R. F. (2021). Skripsi hubungan pengetahuan tentang menstruasi dengan kesiapan menghadapi menarche pada siswi di sdn 38 kota bengkulu (Skripsi). Politeknik Kesehatan Kemenkes Bengkulu.
- Sasmita, I. A., & R. I. (2015). Peran Efikasi Diri dan Dukungan Sosial Teman Sebaya terhadap Penyesuaian Diri Mahasiswa Tahun Pertama Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. *Jurnal Psikologi Udayana*, 2.
- Setiawati, S. E. (2015). Pengaruh stres terhadap siklus menstruasi pada remaja. *Jurnal MAJORITY*. 4(1), 94–98.
- Sekarina, D. P. (2020). Hubungan antara dukungan sosial orangtua dengan kecemasan menghadapi dunia kerja pada siswa kelas xii smk yudya karya Magelang. *Jurnal Empati*, 7(1), 381-386.
- Sinaga, S. E. N. (2015). Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Status Menarche di SMP X di Rangkabitung. *Ners Journal*, 3(2), 34–43.

- Sommer M, Caruso BA, Sahin M, Calderon,T.,Cavill S., Mahon T, et al. (2016) A Time for Global Action: Addressing Girls' Menstrual Hygiene Management Needs in Schools. PLoS Med13(2):e1001962.<https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001962>. diakses tanggal 29 oktober 2019.
- Sumpter and B. Toronde, (2023). A systematic review of the health and social effects of menstrual hygiene management. PLoS One, vol. 8, no. 4, Article ID e62004.
- Varghese, P. J. Prakash, and L. Viswanath,(2019). A study to identify the menstrual problems and related practices among adolescent girls in selected higher secondary school in Thiruvananthapuram, Kerala, India. Journal of South Asian Federation of Obstetrics and Gynaecology, vol. 11, no. 1, pp. 13–16.
- Wakhidah, U. & Wijayanti (2014). Hubungan tingkat pengetahuan remaja putri tentang infeksi genitalia eksterna dan perilaku vulva hygiene kelas XI di MAN 1 Surakarta. Jurnal Kebidanan,6(1): 33-42
- Wibawati, F. H. (2021). Hubungan Aktivitas Fisik dengan Kejadian Dismenore Pada Siswi di SMK Kesehatan Pelita Kabupaten Bogor. Jurnal Ilmiah Wijaya, 13(2), 1–10. www.jurnalwijaya.
- Widarini, N. P., Maryanthi, N. T., Nyoman, N., & Witari, D. (2023). Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Dengan Perilaku Personal Hygiene Menstruasi Pada Remaja Putri Di

Denpasar Tahun 2022. Jurnal Kesehatan Reproduksi.Vol. 14(1), 19–28.

Wilis,D.,S., & Wintarsih (2024). Efektivitas Pendidikan Kesehatan Metode Peer Group Terhadap Pengetahuan, Sikap, Dan Perilaku Personal Hygiene Saat Menstruasi Pada Siswi Kelas 10 Di SMA Perguruan Rakyat 2. MANUJU: Malahayati Nursing Journal, Volume 6 Nomor 3 Tahun 2024 Hal 1222-1228

GLOSARIUM

D

DIMATA (*Swedish Masase Therapy*) : Teknik pijat terapeutik yang berfokus pada meningkatkan sirkulasi darah, meredakan ketegangan otot, dan mengurangi stres.

F

Fast Food (makanan cepat saji) : Jenis makanan yang bisa dipersiapkan dandisajikan dalam waktu cepat sehingga dapat segera dikonsumsi.

HPV (*Human Papiloma Virus*) : Virus yang dapat menyebabkan infeksi di permukaan kulit, serta berpotensi menyebabkan kanker serviks.

FSH (*Follicle Stimulating Hormone*) : Hormon yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak yang bertanggung jawab untuk mengatur produksi sel telur pada wanita dan sperma pada pria.

I

IMT (Indeks Masa Tubuh) : Ukuran yang digunakan untuk mengetahui status gizi seseorang yang didapatkan dari perbandingan berat dan tinggi badan.

ISK (Infeksi Saluran Kemih) : Kondisi ketika organ yang termasuk ke dalam sistem kemih mengalami infeksi, biasanya uretra dan kandung kemih.

L

Leukore (keputihan). : Keadaan di mana adanya lendir putih atau bening yang keluar dari organ intim kewanitaan seorang perempuan, yaitu melalui vagina tanpa bisa dikendalikan oleh tubuh.

LH (*Luteinizing Hormone*) : Hormon yang bekerja sama dengan FSH untuk mengatur siklus menstruasi dan ovulasi pada wanita dan mengatur produksi hormone testosteron sehingga

testis bisa berfungsi dengan baik selama masa reproduksi pada pria.

M

- Menarche* : Menstruasi pertama kali pada seorang wanita yang menandai awal masa subur.
- MHM (*Menstrual Hygiene Management*) : Merupakan pengelolaan kebersihan dan kesehatan pada saat perempuan mengalami menstruasi.

O

- ODHA(Orang Dengan HIV/AIDS) : Merujuk pada individu yang telah positif terinfeksi HIV/AIDS.
- OW (*Over Weight*) : Kondisi ketika berat badan melebihi ukuran berat badan normal.

P

- Peer Support* (Dukungan teman sebaya) : Pemberian dukungan yang berupa perhatian secara emosi, pemberian sikap menghargai, pemberian bantuan dapat berupa materi ataupun non materi dari teman yang usianya hampir sama.
- PMS (*Pre Menstrual Syndrom*) : Sindrom pramenstruasi adalah gejala-gejala yang dialami wanita sebelum memasuki masa menstruasi.
- PRP(Penyakit Radang Panggul) : Infeksi pada organ reproduksi wanita, seperti serviks, rahim, dan ovarium. Salah satu penyebab paling sering dari radang panggul adalah infeksi menular seksual.
- Psychological Well-Being* : Gambaran kesehatan psikologis individu yang disesuaikan berdasarkan pemenuhan fungsi psikologi positif.
- PV(Pruiritas Vulvae) : Sensasi rasa gatal parah yang muncul dari organ genetalia perempuan.

S

SADARI (Pemeriksaan Payudara Sendiri) <i>Sense of Control</i>	:	Aktivitas untuk memeriksa, meraba ataupun melihat payudara sendiri untuk mendeteksi dini kelainan pada payudara
T	:	Kemampuan mengatasi stress.
TATO (<i>Tapping Touch</i>)	:	Teknik perawatan secara menyeluruh yang menggunakan sentuhan dan irama.
U	:	
UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund)	:	Organisasi PBB yang berdedikasi untuk melindungi hak-hak anak di seluruh dunia. Mengutip dari berbagai sumber, keberadaan UNICEF sebagai lembaga atau organisasi yang berfokus pada anak-anak bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup anak maupun wanita yang berada di negara-negara berkembang.
W	:	
WHO (<i>World Health Organization</i>)	:	Otoritas pengarah dan koordinator Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk kesehatan masyarakat global.

PROFIL PENULIS



Ns.Umi Aniroh,M.Kes. Lahir di Semarang, 14 Agustus 1974. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan Fak.Kedokteran UGM tahun 2001. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Diponegoro lulus pada tahun 2013.

Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1998 sebagai staf pengajar di Akademi Keperawatan Ngudi Waluyo. Saat ini penulis bekerja di Universitas Ngudi Waluyo mengampu mata kuliah Keperawatan Maternitas, Keperawatan Kesehatan Reproduksi serta Pendidikan dan Promosi Kesehatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu publikasi penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: umianiroh3@gmail.com

PROFIL PENULIS



Ns. Tina Mawardika., M.Kep., Sp.Kep.Mat. Dosen Prodi S1 Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Ngudi Waluyo Ungaran, Seorang Penulis dan Dosen Prodi S1 Keperawatan & Profesi Ners di Universitas Ngudi Waluyo Ungaran. Lahir pada tanggal 06 Agustus 1988 di Sragen. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Menamatkan

pendidikan program Sarjana (S1) pada tahun 2010 & Profesi Ners di Universitas Ngudi Waluyo Ungaran pada tahun 2011 dan menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) pada tahun 2017 & Spesialis Keperawatan Maternitas di Universitas Indonesia pada tahun 2018. Hingga kini selain mengajar, juga aktif di beberapa organisasi seperti Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Penulis juga aktif sebagai pengelola jurnal serta menulis hasil penelitian yang telah dipublikasikan pada Jurnal International yang terindeks Scopus maupun Jurnal Nasional terindeks Sinta. Dengan ketekunan, motivasi yang tinggi untuk terus belajar dan berusaha penulis telah berhasil meraih prestasi berupa publikasi hasil hibah penelitian pada Jurnal International terindeks Scopus.

Scopus.ID: 24476171900

ORCID.ID: 0000-0002-0316-8226

googlescholar.ID: eNNrr6UAAAAJ; SintaID: 6753691

<https://www.youtube.com/@tinamawardika>

E-mail: tinamawardika@unw.ac.id; tinamawardika@gmail.com
@tinamawardika@mawar.dhica: Mawar Dhica

SINOPSIS BUKU

Buku ini membahas tentang pentingnya peran dukungan sebaya (*peer support*) dalam upaya peningkatan pengetahuan dan sikap remaja dalam *menstrual hygiene management*, yang harapannya dengan pengetahuan dan sikap yang baik dari remaja, akan mendorong terjadinya perubahan perilaku dari remaja tersebut.

Manajemen kebersihan selama masa menstruasi pada remaja yang buruk merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya risiko infeksi serta gangguan-gangguan kesehatan pada sistem reproduksi seperti infertilitas, yang mestinya risiko ini sangat memungkinkan untuk dapat dicegah jika pengetahuan, sikap serta perilaku pen jagaan kebersihan selama menstruasi dilakukan secara tepat dan mendapatkan dukungan yang tepat pula, seperti dukungan dari kelompok teman sebayanya. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep dasar remaja, *menstrual hygiene management* serta peran dukungan kelompok teman sebaya.

Buku ini tidak hanya menyasar individu sebagai pembaca, tetapi juga memberikan wawasan kepada para profesional kesehatan, masyarakat, dan organisasi terkait dalam upaya bersama untuk mewujudkan generasi yang sehat secara produktif. Berdasar hasil penelitian ini disarankan pihak sekolah mengagendakan kegiatan edukasi secara rutin dengan bekerjasama dengan instansi pendidikan kesehatan maupun pihak dinas kesehatan atau puskesmas dan diharapkan para remaja putri dapat meningkatkan dukungan kepada teman sebayanya, mengakses informasi melalui media sosial maupun berdiskusi dengan orang tua mereka tentang *menstrual hygiene management* untuk meningkatkan pengetahuan dan sikapnya.

Buku ini membahas tentang pentingnya peran dukungan sebaya (peer support) dalam upaya peningkatan pengetahuan dan sikap remaja dalam menstrual hygiene management, yang harapannya dengan pengetahuan dan sikap yang baik dari remaja, akan mendorong terjadinya perubahan perilaku dari remaja tersebut. Manajemen kebersihan selama masa menstruasi pada remaja yang buruk merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya risiko infeksi serta gangguan-gangguan kesehatan pada sistem reproduksi seperti infertilitas, yang mestinya risiko ini sangat memungkinkan untuk dapat dicegah jika pengetahuan, sikap serta perilaku penjagaan kebersihan selama menstruasi dilakukan secara tepat dan mendapatkan dukungan yang tepat pula, seperti dukungan dari kelompok teman sebayanya. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep dasar remaja, menstrual hygiene management serta peran dukungan kelompok teman sebaya. Buku ini tidak hanya menyasar individu sebagai pembaca, tetapi juga memberikan wawasan kepada para profesional kesehatan, masyarakat, dan organisasi terkait dalam upaya bersama untuk mewujudkan generasi yang sehat secara produktif. Berdasar hasil penelitian ini disarankan pihak sekolah mengagendakan kegiatan edukasi secara rutin dengan bekerjasama dengan instansi pendidikan kesehatan maupun pihak dinas kesehatan atau puskesmas dan diharapkan para remaja putri dapat meningkatkan dukungan kepada teman sebayanya, mengakses informasi melalui media sosial maupun berdiskusi dengan orang tua mereka tentang menstrual hygiene management untuk meningkatkan pengetahuan dan sikapnya.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919

